

ПРОГРАММА ВЛГД (метод К. П. Бутейко) — 8 недель

Пациентка: Ж, 48 лет | **Дата актуальности данных и старта:** 02.09.2026 | **Версия документа:** 1.0
Период программы: 02.09.2026 — 27.10.2026 | **Контрольные точки:** конец недели 4 (29.09.2026), конец недели 8 (27.10.2026) **Статус:** консервативный сценарий, выдан при неполных объективных данных (см. разделы «Допущения» и «Рекомендованные обследования» — раздел 15/16 Части 2)

Часть 1 — разделы 1–8.

1. Резюме профиля + оценка достижимости цели

1.1. Сводка профиля

Параметр	Значение	Влияние на программу
Возраст, пол	Ж, 48 лет	Нейтрально
ИМТ	27 (избыточная масса)	Фактор храпа и риска СОАС (синдром обструктивного апноэ сна — повторяющиеся остановки дыхания во сне); фактор снижения КП
Основной диагноз	Бронхиальная астма, в анамнезе приступ	Определяет весь блок безопасности; запрет форсированных задержек
Аллергия	Амброзия, август–сентябрь, Краснодар	Недели 1–4 = пик сезона. Это главный ограничитель прогрессии
Базисная терапия	Пульмикорт (будесонид — ингаляционный глюкокортикостероид, ИГКС, противовоспалительный препарат для бронхов) через небулайзер, Монтелукаст, Цетрин (цетиризин), Нозефрин (мометазон, спрей в нос)	Не меняем. Программа работает по верху
КДБА (короткодействующий бета-2-агонист — ингалятор скорой помощи, снимающий спазм бронхов за минуты)	Сейчас не используется	Хороший признак текущего контроля; служит индикатором стоп-критерия
Объективная функция лёгких	Спирометрия и ОФВ1 (объём форсированного выдоха за 1-ю	Программа стартует на «слепом» функциональном

Параметр	Значение	Влияние на программу
	секунду — сколько воздуха вы выдуваете за первую секунду резкого выдоха) — отсутствуют . АСТ не проводился	фоне → отсюда жёсткий приоритет ПСВ-мониторинга
ПСВ (пиковая скорость выдоха — максимальная скорость струи воздуха на резком выдохе, измеряется пикфлоуметром)	Прибор есть, «личный лучший» не установлен	Прогрессия заблокирована до накопления baseline 10–14 дней
Сон	Сильный храп, апноэ не верифицировано, полисомнографии нет; просыпается отдохнувшей	Ночной компонент (пластырь) — под запретом на старте , см. раздел 9
Ночная сухость во рту	Есть, с пробуждениями	Прямой маркёр ротового дыхания во сне; вторичная цель №1
ЖКБ	Неподвижные конкременты в жёлчном пузыре	Ограничение амплитуды диафрагмальной работы, тайминг относительно еды
Прочее	АД в норме, сердце в норме, ЦЖ в норме, ГЭРБ/эпилепсии/мигрени нет, полипов и искривления перегородки нет	Снимает часть стандартных противопоказаний
Тревожность	Ситуативная	Учтено в разделе 11
Работа	Длительные клиентские сессии, много речи, сидячая поза	Отдельный блок микротехник (раздел 10)
Активность	7 000–10 000 шагов, кардио нет	База для блока ходьбы (раздел 12.3)

1.2. Baseline и целевые метрики

Метрика	Baseline на 02.09.2026	Цель на 27.10.2026	Как измеряется
КП (контрольная пауза)	20 сек, утро, сидя, стабильно	30 сек	Раздел 3.1
Ночные пробуждения с сухостью во рту	Есть (частота уточняется дневником)	0 за 7 ночей подряд	Дневник, колонка «Сухость_рта_утром»

Метрика	Baseline на 02.09.2026	Цель на 27.10.2026	Как измеряется
Частота дыхания в покое	~16/мин (оценочно, требуется корректный замер)	10–12/мин	Раздел 3.4
Подъём на 5-й этаж	С одышкой	Подъём в ровном темпе, дыхание носом на всём подъёме, восстановление ЧД до исходной за ≤ 90 сек	Раздел 12.3
ПСВ	Не установлена	Личный лучший установлен; $\geq 80\%$ в $\geq 90\%$ утренних замеров недель 5–8	Раздел 3.2
АСТ (Asthma Control Test — опросник контроля астмы, 5 вопросов, 5–25 баллов)	Не проводился	≥ 20 на неделях 4 и 8	Раздел 3.3

1.3. Оценка достижимости КП 30 сек за 8 недель

Цель я не переопределяю. Даю письменную оценку, как вы просили.

Вывод: цель достижима, но не гарантирована. Оцениваю вероятность выхода на устойчивые 30 сек к 27.10.2026 как умеренную — примерно один шанс из двух. Это честная оценка, а не осторожность формулировки.

Расчёт, на котором она построена:

Период	Условия	Ожидаемая динамика КП
Недели 1–2 (02.09–15.09)	Пик амброзии, обучение технике, набор baseline ПСВ, прогрессии нет	20 → 19–21. Возможно временное снижение до 17–18 в пыльцевые пики. Это ожидаемо
Недели 3–4 (16.09–29.09)	Хвост сезона, минимальная прогрессия	20 → 21–23
Недели 5–6 (30.09–13.10)	Послесезонное окно, основная фаза роста	22 → 25–27
Недели 7–8 (14.10–27.10)	Консолидация, выход на целевой уровень	26 → 28–32

Что играет за достижение цели:

- КДБА не используется — значит, бронхи сейчас относительно спокойны на фоне базиса;

- носовое дыхание днём свободное, анатомических препятствий в носу нет (нет полипов, нет искривления перегородки) — вы не тратите недели на восстановление носового дыхания;
- baseline 20 сек — это не «дно», а средняя стартовая позиция; шаг 20 → 30 сек по методу считается стандартным первым этапом;
- у вас есть сильный ресурс, который у большинства пациентов приходится развивать месяцами: точное и дифференцированное различие собственных телесных состояний. Это прямо ускоряет освоение уменьшенного дыхания, потому что вся техника строится на удержании определённой степени воздушного голода, а не на счёте;
- второй ресурс — дисциплина ведения записей.

Что играет против:

1. **Старт в пик амброзии.** Аллергическое воспаление слизистой дыхательных путей само по себе снижает КП. Первые 2–4 недели — это не рост, а удержание. Мы фактически имеем не 8 недель роста, а 4–5.
2. **Отсутствие объективной функции лёгких.** Нет ОФВ1, нет исходной ПСВ. Первые 10–14 дней уходят на построение точки отсчёта, во время которых прогрессия запрещена.
3. **ИМТ 27 и сильный храп.** Ночное дыхание — вероятно ротовое и, возможно, с эпизодами обструкции. Ночь — это 7–8 часов дыхания против 40–60 минут дневной практики. Если ночью дыхание избыточное, утренняя КП будет упираться в потолок независимо от качества дневных сессий. Это, на мой взгляд, **главный ограничитель именно в вашем случае.**
4. **Низкая физическая активность.** Без аэробной нагрузки прирост КП выше 25–27 сек обычно упирается в плато.
5. **Длительная речевая нагрузка** на клиентских сессиях — это несколько часов в день фактической гипервентиляции (избыточного дыхания), которая «съедает» эффект утренней сессии.

Риски форсирования — прямо и без смягчения:

Риск	Механизм	Как проявится
Бронхоспазм	Резкие и максимальные задержки с последующим глубоким компенсаторным вдохом ртом — известный провокатор у астматиков, особенно на фоне активного аллергического воспаления	Свист, кашель, стеснение в груди во время или в течение 30–60 мин после сессии
Скрытое ухудшение проходимости бронхов	Симптомы могут отставать от функционального ухудшения	Падение утренней ПСВ при субъективно «нормальном» самочувствии
Тревожная сенсibilизация к задержке дыхания	Повторные эпизоды сильного воздушного голода закрепляются как сигнал угрозы	Учащение дыхания при одной мысли о КП, невозможность довести замер
Нарушение сна	Вечерние сессии с высокой нагрузкой повышают активацию	Засыпание > 45 мин, ночные пробуждения
«Гонка за цифрой»	Замер КП превращается в волевой рекорд	Рост цифры КП без роста качества дыхания; цифра

Риск	Механизм	Как проявится
		нестабильна день ото дня, разброс > 4 сек

Правило приоритета, действующее весь курс: при конфликте — сначала безопасность и ПСВ, затем сон, затем КП, затем работоспособность. Если к 27.10.2026 КП составит 26–28 сек при нормализованном ночном дыхании и отсутствии обострений — это хороший результат курса, а не провал. Цель 30 в этом случае переносится на недели 9–12 без всякой драмы.

2. Безопасность

Раздел написан протокольно. Формулировки не смягчаются и обсуждению не подлежат.

2.1. Абсолютные ограничения на весь курс

№	Ограничение	Срок действия
Б-1	Базисная терапия (Пульмикорт, Монтелукаст, Цетрин, Нозефрин) выполняется в назначенном режиме и дозах. Программа не является основанием для снижения, пропуска или отмены любого из препаратов	Весь курс
Б-2	КДБА (ингалятор скорой помощи) находится в зоне досягаемости при каждой дыхательной сессии — в той же комнате, не в сумке в прихожей	Весь курс
Б-3	Максимальная пауза (задержка дыхания до предельного волевого усилия) запрещена	Недели 1–4 — полностью. Недели 5–8 — только по явному разрешению раздела 8, не более 1 раза в неделю, не более 90 % от КП
Б-4	Задержка дыхания выполняется только на выдохе, в положении сидя, с опорой спины. Задержки стоя, при ходьбе, в воде, за рулём — запрещены	Весь курс
Б-5	Задержка дыхания никогда не выполняется до «терпения через силу». Критерий окончания — первый отчётливый позыв вдохнуть	Весь курс
Б-6	Выход из любой задержки — только носом, спокойным вдохом обычного объёма. Вдох ртом или добор воздуха после задержки означает, что задержка была передержана	Весь курс
Б-7	Сессия не проводится ранее чем через 1,5–2 часа после еды	Весь курс

№	Ограничение	Срок действия
Б-8	Сессия не проводится натошак (после ночного перерыва — только после лёгкого приёма пищи и последующей паузы 1,5–2 часа) и не проводится после жирной пищи ранее чем через 3 часа	Весь курс, по ЖКБ
Б-9	Заклеивание рта на ночь запрещено до выполнения условий раздела 9	До верификации ночного дыхания
Б-10	Практика в дни с ПСВ ниже 80 % от личного лучшего проводится только в редуцированном объёме (раздел 8.5), прогрессия остановлена	Весь курс
Б-11	Практика не проводится в течение 30 минут после ингаляции Пульмикорта через небулайзер	Весь курс
Б-12	Практика не проводится при остром респираторном заболевании с температурой, при обострении астмы, при боли в правом подреберье любой интенсивности	Весь курс

2.2. Комментарий по ЖКБ (жёлчнокаменная болезнь) — отдельно, как запрошено

Диафрагмальное дыхание в методе — это не «глубокий вдох животом», а наоборот: уменьшенный по объёму вдох при расслабленной, мягко работающей диафрагме. Диафрагма при движении смещает органы верхнего этажа брюшной полости, включая жёлчный пузырь, и меняет внутрибрюшное давление.

Ваша ситуация: конкременты **неподвижные**. Риск смещения камня и обструкции протока при дыхательной практике я оцениваю как низкий. Но он не нулевой, и режим строится так, чтобы его не повышать:

- 1. Малая амплитуда на старте.** Недели 1–2: экскурсия (движение) передней брюшной стенки на вдохе — минимальная, на уровне «едва заметно глазу». Никаких «полных вдохов животом», никакой техники «выталкивания живота». Это не уступка болезни — это и есть правильное исполнение уменьшенного дыхания.
- 2. Никаких втягиваний живота на задержке,** никаких резких «вакуумов», никакого напряжения брюшного пресса на выдохе. Выдох — пассивный, за счёт расслабления, не за счёт выжимания.
- 3. Тайминг относительно еды.** После приёма пищи жёлчный пузырь сокращается. Практика в этот период не нужна. Отсюда: сессия — не ранее 1,5–2 часов после лёгкой еды, не ранее 3 часов после жирной. Натошак — тоже нет: голодная практика чаще даёт дискомфорт в правом подреберье и тошноту.
- 4. Позиция.** Сидя с прямой опорой, не сгибаясь вперёд, не поджимая живот. Лёжа на правом боку практику не проводить.
- 5. Стоп-признак по ЖКБ:** любая боль, тяжесть, распирающее или тянущее ощущение в правом подреберье во время или в течение 2 часов после сессии — сессия прекращается, запись в дневник, следующая сессия — только через 24 часа и только в объёме недели 1. При повторе — практика приостанавливается, очное обращение.

6. Расширение амплитуды диафрагмальной работы — с недели 3 и только при отсутствии реакций из пункта 5 за все предыдущие сессии.

2.3. Стоп-критерии (согласованный перечень — дословно)

Немедленная остановка сессии:

- свистящее дыхание или кашель во время либо после упражнения;
- потребность в препарате скорой помощи (КДБА);
- ночное пробуждение от нехватки воздуха;
- головокружение.

При повторе любого из перечисленного 2 дня подряд — пауза программы и обращение к очному врачу.

По объективному контролю:

- утренняя ПСВ ниже 80 % от личного лучшего — прогрессия останавливается;
- ПСВ ниже 60 % от личного лучшего — программа останавливается, обращение к врачу.

По сну (приоритет сна выше роста КП именно в этом случае):

- засыпание дольше 45 минут три ночи подряд — снижение нагрузки.

2.4. Развёртка стоп-критериев: что именно делать

Триггер	Действие в момент срабатывания	Действие в этот день	Возврат
Свист / кашель во время или после упражнения	Сессия прекращается на этом вдохе. Сесть, дыхание носом, не задерживать, не углублять. 10 минут покоя. Если через 10 минут свист сохраняется — КДБА по инструкции	Остальные сессии дня отменяются. Измерить ПСВ через 30 мин. Запись в дневник	Раздел 2.6
Потребность в КДБА (в любое время суток, а не только на сессии)	Применить КДБА по инструкции. Практика в этот день прекращается полностью	Измерить ПСВ через 20–30 мин после КДБА и записать. Отметить колонку «КДБА_применён» = Да	Раздел 2.6
Ночное пробуждение от нехватки воздуха	Сесть, дыхание носом. КДБА при сохранении затруднения. Отменить любой ночной компонент (пластырь — если он к тому моменту был начат)	На следующий день: практика в объёме недели 1, без задержек. Утренняя ПСВ обязательна	Раздел 2.6 + немедленный follow-up
Головокружение	Прекратить упражнение немедленно. Прекратить контроль дыхания, дышать	Сессия не возобновляется. Следующая сессия — не	Раздел 2.6

Триггер	Действие в момент срабатывания	Действие в этот день	Возврат
	свободно носом 2–3 минуты, не углубляя. Не вставать 2 минуты	ранее следующего дня и на один шаг ниже	
Повтор любого из четырёх 2 дня подряд	Программа ставится на паузу целиком. Очное обращение к врачу. Самостоятельное возобновление до очного осмотра запрещено	—	Только по решению очного врача
Утренняя ПСВ < 80 % личного лучшего	Прогрессия останавливается. Практика — в редуцированном объёме (раздел 8.5)	Повторить замер ПСВ вечером. Проверить: приём базиса, пылевой день, промывание носа	Раздел 2.6
ПСВ < 60 % личного лучшего	Программа останавливается. КДБА по инструкции. Обращение к врачу. Дыхательные упражнения не выполняются вообще	—	Только по решению очного врача
Засыпание > 45 мин три ночи подряд	Нагрузка снижается на один шаг (раздел 8.4). Вечерняя сессия переносится не позднее чем на 3 часа до сна или заменяется на «дыхание для засыпания» без задержек	—	Раздел 2.6

2.5. Дополнительные стоп-критерии (добавлены мной)

№	Критерий	Действие
Д-1	Боль, тяжесть или распирающие в правом подреберье во время или в течение 2 часов после сессии	Прекратить сессию. 24 часа паузы. При повторе — очное обращение
Д-2	Онемение, покалывание в пальцах или вокруг рта, «мурашки» на лице, ощущение сдавливания головы	Это признаки передозировки нагрузки. Прекратить сессию, свободное носовое дыхание 3 минуты. Следующая сессия — на шаг ниже
Д-3	Сердцебиение с ощущением перебоев во время или после сессии	Прекратить сессию. При повторе на следующей сессии — пауза программы, очное обращение
Д-4	Утренняя КП упала на ≥ 5 сек относительно среднего за предыдущие	Прогрессия остановлена, откат на один шаг, усилить блок элиминации аллергена. Проверить

№	Критерий	Действие
	7 дней и держится 2 дня подряд	ПСВ
Д-5	Разброс ПСВ «утро–вечер» более 20 % от личного лучшего в течение 2 дней подряд	Прогрессия остановлена. Немедленный follow-up (это признак нестабильности бронхов)
Д-6	Появление ночных симптомов (кашель, свист, стеснение в груди), которых не было	Прогрессия остановлена. ПСВ дважды в день. Немедленный follow-up
Д-7	Три и более пропущенных дня практики подряд	Возврат на уровень нагрузки недели, предшествующей текущей; 3 дня удержания, затем прогрессия по общему правилу

2.6. Единое правило возврата к прогрессии после срабатывания стоп-критерия

Правило одно, применяется ко всем случаям, кроме тех, где указано «только по решению очного врача».

Условия возврата (выполняются все три одновременно):

1. 48 часов без единого симптома из списка стоп-критериев;
2. утренняя ПСВ ≥ 80 % от личного лучшего **три дня подряд**;
3. КП утром не ниже, чем среднее за 7 дней до срабатывания, минус 2 сек.

Порядок возврата:

- **Шаг 1.** Возобновление практики на уровне **на один шаг ниже** того, на котором произошло срабатывание (при срабатывании на первой неделе — на уровне «только КП и наблюдение дыхания без задержек»).
- **Шаг 2.** Удержание этого уровня **3 дня** при выполнении всех трёх условий.
- **Шаг 3.** Возврат на исходный уровень. Удержание **3 дня**.
- **Шаг 4.** Только после этого разрешён следующий шаг прогрессии.

Дополнительно: при втором срабатывании одного и того же стоп-критерия в пределах 14 дней срок удержания на каждом шаге удваивается (6 дней вместо 3), и уровень нагрузки на весь остаток соответствующей фазы не превышает уровня, на котором срабатывание не происходило.

2.7. Алгоритм при обострении астмы

Стадия	Признаки	Действия
Ранняя (предвестники)	ПСВ 60–80 % от лучшего; ночные симптомы; кашель; потребность в КДБА 1–2 раза за сутки	Дыхательная программа — только редуцированный объём (раздел 8.5), прогрессия стоп. Базис — строго по назначению. Усилить элиминацию аллергена (раздел 12.1). ПСВ 2 раза в сутки. Follow-up мне в течение 24 часов

Стадия	Признаки	Действия
Развёрнутая	ПСВ < 60 % от лучшего; одышка в покое; потребность в КДБА чаще, чем предписано инструкцией к препарату; ночное пробуждение от нехватки воздуха	Дыхательная программа останавливается полностью. КДБА по инструкции. Очное обращение к врачу в тот же день. Задержки дыхания, уменьшенное дыхание, попытки «продышать приступ» методом Бутейко — запрещены
Угрожающая	Затруднение речи (не можете произнести фразу на одном выдохе), синеватый оттенок губ, спутанность, отсутствие эффекта КДБА	Экстренная медицинская помощь. Немедленно. Никаких дыхательных техник

Отдельно и категорично: метод Бутейко не является средством купирования приступа бронхиальной астмы и не заменяет КДБА. Попытка «переждать» ухудшение на уменьшенном дыхании вместо ингалятора — недопустима.

3. Базовые замеры

3.1. Контрольная пауза (КП)

Что это. Время от спокойного выдоха до **первого** позыва вдохнуть. Это диагностический показатель, а не упражнение. КП не тренируют — КП растёт как следствие изменения дыхания в остальное время суток.

Протокол замера (эталонный, не меняется весь курс):

Шаг	Действие
1	Утро, сразу после пробуждения, до того как встали и начали двигаться. Сидя на кровати, спина с опорой, ноги на полу, руки на бёдрах
2	3–5 минут спокойного носового дыхания, ничего не корректируя
3	Обычный (не глубокий) вдох носом, затем обычный спокойный выдох носом
4	В конце выдоха, на спокойной паузе, зажать нос пальцами. Секундомер — старт
5	Ждать первого отчётливого позыва вдохнуть : первое непроизвольное сокращение диафрагмы, «толчок» или отчётливое желание вдохнуть, которое требует усилия, чтобы его не удовлетворить
6	На этом моменте — стоп секундомера, отпустить нос, вдох носом
7	Контроль корректности: первый вдох после КП должен быть таким же по объёму, как до замера. Если понадобился глубокий вдох, вдох ртом, два-три «добора» — замер выполнен неверно (передержан), цифру записать с пометкой «передержана», в статистику не включать

Дозировка замеров:

Слот	Когда	Обязательность
Утро	Сразу после пробуждения	Обязательно ежедневно. Это основной показатель курса
До сессии	Перед каждой дыхательной сессией	Обязательно
После сессии	Через 2–3 минуты после окончания	Обязательно
Вечер	Перед сном	Желательно

Типичные ошибки:

Ошибка	Признак	Исправление
Замер после глубокого вдоха	Цифра завышена на 5–15 сек, нестабильна	Только обычный вдох, обычный выдох
Терпение «до предела»	После замера — жадный вдох ртом, ощущение «отдышаться»	Останавливаться на первом позыве
Замер после подъёма, движения, кофе	Цифра занижена и нестабильна	Только в постели, до подъёма
Отсчёт «в уме»	Систематическая ошибка	Секундомер
Замер после КДБА или сразу после Пульмикорта	Цифра неинтерпретируема	Не ранее чем через 2 часа

Ориентиры интерпретации (рабочие для этой программы): ваш индивидуальный отсчёт ведём от вашего baseline 20 сек. Абсолютных «нормативов КП» в виде проверенных цифр я вам не привожу — то, что ходит в популярных источниках, я подтвердить не могу. Работаем с динамикой относительно вашей собственной точки отсчёта.

Критерий стабильности показателя: КП считается «установившейся на уровне X», если за 7 подряд утренних замеров среднее $\geq X$ и разброс между минимумом и максимумом ≤ 4 сек. Именно по этому правилу мы будем фиксировать достижение цели 30 сек — одна удачная цифра целью не считается.

3.2. ПСВ и зоны — с нуля

Что это. ПСВ (пиковая скорость выдоха) — максимальная скорость струи воздуха при резком коротком выдохе, л/мин. Показывает, насколько свободны бронхи. Для вас это **единственный объективный контроль безопасности** до тех пор, пока не сделана спирометрия.

Подготовка прибора: бегунок (стрелка) устанавливается на «0» перед каждой попыткой. Прибор держится горизонтально, пальцы не перекрывают шкалу и прорезь бегунка.

Техника замера:

Шаг	Действие
1	Встать (стоя — стандартное положение; если стоя неудобно, всегда сидя с прямой спиной — но одно и то же положение весь курс)
2	Бегунок на «0»
3	Сделать максимально полный вдох ртом — до предела
4	Плотно обхватить мундштук губами, язык не закрывает отверстие
5	Один резкий, короткий, взрывной выдох — как задуть свечу с той стороны комнаты. Не «долгий выдох до конца», а именно короткий мощный толчок
6	Записать цифру. Бегунок на «0»
7	Повторить 3 раза с интервалом 15–30 секунд
8	В дневник записывается наибольшая из трёх цифр

Контроль качества: три попытки должны различаться не более чем на 20 л/мин. Если разброс больше — техника нестабильна, сделать 4-ю и 5-ю попытку. Кашель во время замера — попытка не засчитывается.

Тайминг относительно терапии — важно:

Ситуация	Правило
Утренний замер	До ингаляции Пульмикорта и до всех препаратов, сразу после пробуждения и туалета, до завтрака
Вечерний замер	Перед вечерней ингаляцией Пульмикорта (если она есть), примерно в одно и то же время
После КДБА	Дополнительный замер через 20–30 мин после применения — записывать отдельно, в поле «Заметки»
После небулайзера	Ближайший плановый замер — не ранее чем через 30 мин
Перед дыхательной сессией	На неделях 1–2 и в любой день с симптомами — обязательно

Расписание замеров ПСВ по курсу:

Период	Частота
Недели 1–2 (набор baseline)	2 раза в сутки: утро и вечер, ежедневно, без пропусков
Недели 3–8, стабильное состояние	1 раз в сутки, утро
Любой день с симптомами, с ПСВ < 80 %, при пыльцевом пике, при срабатывании стоп-критерия	2 раза в сутки

Установление «личного лучшего»:

- Личный лучший = максимальная цифра, зафиксированная за 10–14 дней стабильных ежедневных замеров при отсутствии симптомов.
- **Проблема вашего случая:** первые 14 дней приходятся на пик амброзии. Значение, полученное в сезон, почти наверняка занижено. Поэтому:

Этап	Что делаем
Дни 1–14 (02.09–15.09)	Набираем сезонный ориентир — максимум за период. Он используется как рабочий с 16.09
Дни 29–42 (30.09–13.10, послесезонное окно)	Пересчёт личного лучшего. Берём максимум за эти 14 дней. Если он выше сезонного ориентира — зоны пересчитываются, и все пороги сдвигаются вверх
Дальше	Личный лучший пересматривается вверх, если появилась цифра выше на ≥ 20 л/мин, подтверждённая ещё раз в течение 7 дней. Вниз личный лучший не пересматривается никогда самостоятельно

Таблица зон (заполняете сами после расчёта):

Зона	Формула	Ваше значение, л/мин	Что означает	Что делать
Зелёная	≥ 80 % от личного лучшего	$ЛЛ \times 0,8 =$ ___ и выше	Бронхи проходимы	Программа по плану, прогрессия разрешена
Жёлтая	60–79 %	от $ЛЛ \times 0,6 =$ ___ до ___	Ухудшение проходимости	Прогрессия остановлена. Редуцированный объём. ПСВ 2х/сут. Базис строго. Follow-up
Красная	< 60 %	ниже $ЛЛ \times 0,6 =$ ___	Значимая обструкция	Программа остановлена. КДБА. Врач

Пример арифметики (числа условные, для проверки расчёта): если личный лучший = 400 л/мин, то граница 80 % = 320 л/мин, граница 60 % = 240 л/мин. Зелёная зона — 320 и выше, жёлтая — 240–319, красная — ниже 240.

Должные (нормативные для возраста и роста) значения ПСВ я вам намеренно не привожу: они существенно расходятся между таблицами и для управления программой бесполезны. **Нужен индивидуальный замер** — работаем только от вашего личного лучшего.

3.3. АСТ (Asthma Control Test) — провести на старте

Опросник контроля астмы: 5 вопросов, каждый оценивается от 1 до 5 баллов, сумма 5–25. Проводится за 4 недели назад.

№	Вопрос	Шкала (1 → 5)
1	Как часто за последние 4 недели астма мешала вам выполнять обычные дела (работа, дом, учёба)?	1 — всё время ... 5 — совсем не мешала
2	Как часто за последние 4 недели вы отмечали у себя затруднённое дыхание?	1 — чаще, чем раз в день ... 5 — ни разу
3	Как часто за последние 4 недели симптомы астмы (свист, кашель, стеснение в груди, одышка) будили вас ночью или раньше обычного утром?	1 — 4 ночи в неделю и чаще ... 5 — ни разу
4	Как часто за последние 4 недели вы использовали ингалятор скорой помощи?	1 — 3 раза в день и чаще ... 5 — ни разу
5	Как бы вы оценили, насколько вам удавалось контролировать астму за последние 4 недели?	1 — совсем не удавалось ... 5 — полностью удавалось

Интерпретация:

Сумма	Значение	Следствие для программы
25	Полный контроль	Программа по плану
20–24	Хороший контроль	Программа по плану, повышенное внимание к ПСВ
< 20	Контроль недостаточен	Прогрессия не начинается. Работаем только в объёме недели 1–2 (наблюдение дыхания, дневной контроль, элиминация аллергена) до повышения АСТ ≥ 20 или до очной консультации

Когда проводить: 02.09.2026 (сегодня), 29.09.2026 (конец недели 4), 27.10.2026 (конец недели 8).

Записывать результат в «Заметки» дневника.

3.4. Частота дыхания в покое (ЧД) — методика корректного замера

Здесь есть техническая сложность: как только человек начинает считать собственное дыхание, оно меняется. Ваш baseline «~16» — оценочный, ему доверять нельзя. Методика:

Вариант 1 — основной (самозамер с отсрочкой внимания):

Шаг	Действие
1	Сидя, спина с опорой, минимум 10 минут в покое, без разговора, без телефона
2	Положить ладонь на нижние рёбра сбоку — не на живот (так меньше вмешательства в паттерн)
3	Включить таймер на 2 минуты, не глядя на него
4	Считать выдохи , а не вдохи. Считать пассивно, не корректируя
5	Результат за 2 минуты разделить на 2 = ЧД в минуту

Шаг	Действие
6	Повторить 3 раза с интервалом 3–5 минут. Записать медиану (среднее из трёх, отбросив крайние, если разброс > 3)

Вариант 2 — контрольный (независимый наблюдатель): попросить кого-то посчитать ваши дыхательные движения в течение 60 секунд, не предупреждая заранее, когда именно начнётся счёт.

Расписание: baseline — три дня подряд (02–04.09), утром после КП и вечером. Далее — 1 раз в неделю, в воскресенье вечером, в одинаковых условиях. Записывать в «Заметки».

Целевой коридор: 10–12/мин к концу курса. Важно: цель — не «дышать реже усилием», а прийти к более редкому дыханию как к автоматическому состоянию. Волевое урежение до 8/мин с последующими вздохами — это ухудшение, а не улучшение.

3.5. Стартовый пакет замеров — что сделать сегодня, 02.09.2026

№	Действие	Время
1	КП утренняя (если пропущено — начать с завтра)	5 мин
2	ПСВ утро + вечер, 3 попытки каждый раз	5 + 5 мин
3	АСТ, записать сумму	5 мин
4	ЧД в покое, 3 замера	20 мин
5	Развернуть дневник (раздел 13), внести первую строку	10 мин
6	Проверить срок годности КДБА и положить его в комнату, где будете практиковать	2 мин
7	Блок элиминации аллергена (раздел 12.1) — запустить сегодня же, до первой дыхательной сессии	вечер

4. Техники

Общее замечание по всем техникам. Метод Бутейко в его стандартном изложении состоит не из «упражнений» в спортивном смысле, а из одной центральной задачи: **устойчиво уменьшить глубину дыхания и приблизить дыхание к спокойному, малозаметному, носовому, диафрагмальному, с естественной паузой после выдоха**. Всё остальное — вспомогательные приёмы и способы контроля. Поэтому не удивляйтесь скудости арсенала: это не упрощение под ваш профиль, это и есть метод.

Телесные маркёры я описываю нейтрально и феноменологически — как рабочий язык, а не как объяснение.

Т-1. Базовая позиция и наблюдение дыхания (без вмешательства)

Параметр	Содержание
Цель	Установить исходное положение и научиться удерживать наблюдение за дыханием, не изменяя его. Обязательная преамбула любой сессии
Исполнение	1. Сидя, сидищные бугры равномерно нагружены, стопы полностью на полу, колени под углом около 90°. 2. Спина имеет опору (спинка стула, стена) — не «держится» мышцами. 3. Плечи опущены, руки лежат на бёдрах ладонями вниз, не сцеплены. 4. Подбородок слегка опущен, шея длинная, челюсть не сжата, зубы разомкнуты, язык лежит на нёбе за верхними зубами, губы сомкнуты. 5. 2–3 минуты — просто дышать носом, отмечая: где в теле есть движение на вдохе, какова длительность вдоха относительно выдоха, есть ли пауза после выдоха, есть ли периодические глубокие вздохи
Дозировка	2–3 минуты в начале каждой сессии
Признаки правильного выполнения	Движение на вдохе преимущественно в нижних рёбрах и верхней части живота; плечи и ключицы неподвижны; выдох пассивный, длиннее вдоха; после выдоха есть короткая естественная пауза
Типичные ошибки	Наблюдение немедленно превращается в углубление дыхания; попытка «сделать правильно» вместо регистрации того, что есть
Телесные маркёры	Опора: вес распределён на таз и стопы, а не на поясницу. Тонус: если появляется усилие в межлопаточной области — спина не имеет опоры. «Где перехватывает»: если наблюдение вызывает подъём напряжения в горле или под ключицами — вы уже начали регулировать дыхание, вернитесь к пассивной регистрации

Т-2. Уменьшенное дыхание (основная техника метода)

Параметр	Содержание
Цель	Снизить минутный объём дыхания и повысить переносимость углекислого газа (CO ₂). Гипокапния (пониженное содержание углекислого газа в крови из-за избыточного дыхания) — то состояние, от которого мы уходим. Это техника, которая и даёт рост КП
Исполнение	1. Базовая позиция (Т-1). 2. Замерить КП, записать. 3. Уменьшить глубину вдоха : вдох носом, тише и меньше обычного, примерно на 20–30 % по ощущению объёма. Не укорачивать вдох резко — сделать его <i>мягче и тише</i> . 4. Выдох — пассивный : не выдыхать, а <i>отпускать</i> . Мышцы живота не участвуют. 5. После выдоха — не форсируя, позволить возникнуть короткой естественной паузе (1–2 сек на старте) и на ней начать следующий вдох. 6. Удерживать состояние лёгкой, переносимой нехватки воздуха — такой, при которой вы можете продолжать 3–4 минуты и разговаривать вы бы смогли. 7. Через 3–4 минуты — 1–2 минуты свободного носового дыхания (отдых). 8. Повторить цикл. 9. В конце — КП, записать
Дозировка (стартовая, недели)	4 цикла × 3 мин работы + 1 мин отдыха = ~16 мин на сессию

Параметр	Содержание
1–2)	
Дозировка (недели 5–8, целевая)	4–5 циклов × 4–5 мин работы + 1 мин отдыха
Шкала интенсивности воздушного голода — рабочая, ею пользуемся весь курс	0 — дыхания не замечаете. 1 — дыхание чуть заметно. 2 — отчётливое желание вдохнуть глубже, легко переносится, можете удерживать минутами. 3 — выраженное желание, требует внимания, удержание 1–2 минуты. 4 — сильное, на грани срыва, появляется напряжение в шее и плечах. 5 — срыв, глубокий вдох
Рабочая зона	Недели 1–4: интенсивность 2. Недели 5–8: интенсивность 2–3. Выше 3 — не работаем никогда. Признак выхода за границу: непроизвольный глубокий вдох, напряжение мышц шеи, необходимость волевого усилия «терпеть»
Признаки правильного выполнения	Через 2–4 минуты: потепление кистей, стоп, лица; лёгкая испарина на лбу или спине; повышение слюноотделения; иногда зевота; ощущение тепла в грудной клетке; в конце сессии — КП выше, чем в начале, на 2–5 сек
Типичные ошибки	1. Задержка дыхания вместо уменьшенного дыхания (дыхание останавливается вместо того, чтобы стать меньше). 2. Активный выдох мышцами живота — самая частая. 3. Урежение дыхания вместо уменьшения глубины: паузы растягиваются, а вдох становится глубоким — минутный объём не падает. 4. Работа на интенсивности 4–5 с последующим срывом в глубокий вдох — обнуляет весь цикл. 5. Напряжение верхнего плечевого пояса
Телесные маркёры	Опора: чем меньше дыхание, тем отчётливее должен ощущаться вес тела на стуле. Диафрагма: движение под мечевидным отростком и по нижней рёберной дуге — минимальное, но непрерывное и мягкое; жёсткость, «замирение» в этой области = задержка вместо уменьшения. Тонус: трапеции, лестничные мышцы шеи, челюсть — должны оставаться неизменными на протяжении всего цикла; их подключение — сигнал избыточной нагрузки. «Где перехватывает»: типичное место — надгортанная область и переднее основание шеи; ощущение сжатия там означает интенсивность ≥ 4 , снижайте немедленно

Т-3. Малая пауза после выдоха

Параметр	Содержание
Цель	Восстановление естественной паузы в дыхательном цикле; мягкий инструмент снижения минутного объёма без выраженного воздушного голода. Безопасная альтернатива задержкам в сезон

Параметр	Содержание
Исполнение	Обычный вдох носом → пассивный выдох носом → пауза 2–5 секунд (не более) → следующий вдох, обычный по объёму, без добора . Повторить 8–10 раз, затем 1 минута свободного дыхания
Дозировка	Недели 1–4: 2–3 подхода по 8–10 повторов в составе сессии. Также используется как микропрактика в течение дня
Признаки правильного выполнения	Вдох после паузы — такой же, как до неё. Никакого «отдышивания»
Типичные ошибки	Растягивание паузы до 8–10 сек — это уже задержка, а не малая пауза; вдох после паузы становится глубоким
Телесные маркёры	На паузе тело остаётся мягким; если на паузе появляется тяга «подтянуться» вверх грудной клеткой — пауза длинновата

Т-4. Контролируемая задержка на выдохе (укороченная КП, тренировочная)

Параметр	Содержание
Цель	Тренировка переносимости CO ₂ на дозированном уровне
Δ Допуск	Недели 1–4 — не используется. Вводится не ранее недели 5 и только при выполнении условий раздела 8
Исполнение	Обычный вдох → пассивный выдох → задержка длительностью не более 60 % от текущей утренней КП (при КП 22 сек — 13 сек) → выход носом , обычный вдох → далее 1 минута уменьшенного дыхания. Повторить 3–5 раз с интервалом в 1 минуту уменьшенного дыхания
Дозировка	3–5 повторов, 1 раз в сессии, не более 2 сессий в день
Признаки правильного выполнения	После задержки дыхание восстанавливается в течение 2–3 циклов, без глубоких вдохов
Типичные ошибки	Задержка «на максимум»; выход ртом; после задержки — компенсаторная гипервентиляция, которая полностью обнуляет эффект
Телесные маркёры	Допустимо: 1–2 произвольных сокращения диафрагмы в конце задержки. Недопустимо: волна напряжения от диафрагмы вверх к горлу, сжатие в груди — немедленно прекратить

Т-5. Носовая разблокировка (при заложенности носа)

Параметр	Содержание
Цель	Снять умеренную заложенность носа без сосудосуживающих капель. В сезон амброзии — рабочая техника ежедневного применения
Исполнение	1. Сидя. 2. Обычный вдох носом → обычный выдох носом → зажать нос пальцами. 3. Удерживая нос, медленно покачивать головой (вверх-вниз или из стороны в сторону) до отчётливого позыва вдохнуть. 4. Отпустить нос, вдохнуть носом , дыхание при этом удерживать спокойным и уменьшенным 30–60 секунд, не позволяя себе «отдышаться» ртом. 5. Повторить через 1 минуту. 3–6 повторов
Дозировка	По потребности, до 6 подходов подряд, до 4 раз в день
Ограничение в вашем случае	Задержка при этом — до первого позыва , не дольше. С осторожностью в дни с ПСВ < 80 %
Признаки правильного выполнения	Носовое дыхание облегчается через 2–4 подхода
Типичные ошибки	Вдох ртом после подхода — обнуляет эффект и усиливает заложенность
Порядок применения	Сначала промывание носа солевым раствором (раздел 12.1) и Нозефрин по схеме, затем — Т-5. Не наоборот

Т-6. Дыхание для засыпания

Параметр	Содержание
Цель	Снизить активацию перед сном, войти в сон на носовом дыхании. Прямая работа со вторичной целью №1
Исполнение	1. Лёжа на левом боку или на животе (позиционная терапия, раздел 9), подушка поддерживает шею в нейтральном положении. 2. Язык на нёбе, губы сомкнуты, челюсть расслаблена. 3. Уменьшенное дыхание интенсивности 1–2 (не выше), без задержек, без счёта. 4. Продолжать 10–15 минут или до засыпания. 5. Если через 15 минут не заснули — прекратить контроль дыхания полностью, дышать свободно носом
Дозировка	Ежедневно перед сном, весь курс
Стоп	Если техника удлиняет засыпание (> 45 мин трижды подряд) — отменяется, заменяется на простое наблюдение дыхания без коррекции

Т-7. Восстановление дыхания после речи (для работы)

Параметр	Содержание
Цель	Погасить накопленную за клиентскую сессию гипервентиляцию

Параметр	Содержание
Исполнение	1. Закрыть рот, дышать носом. 2. 60–90 секунд уменьшенного дыхания интенсивности 2. 3. Затем 3 малые паузы (Т-3). 4. Не разговаривать в течение этого времени
Дозировка	После каждой клиентской сессии, между сессиями. 1,5–2 минуты
Признаки правильного выполнения	Ощущение сухости во рту уменьшается; дыхание становится тише

Т-8. Ходьба с носовым дыханием (аэробный компонент)

Параметр	Содержание
Цель	Единственный способ пробить плато КП выше 25–27 сек. Физическая нагрузка на носовом дыхании — основной естественный тренажёр переносимости CO ₂
Исполнение	Ходьба в темпе, при котором дыхание остаётся носовым и не переходит в ротовое . Рот закрыт всё время. Как только появляется потребность открыть рот — темп снижается
Дозировка	Раздел 12.3 (прогрессия по неделям)
Ограничение	Задержки дыхания при ходьбе запрещены весь курс (Б-4). В сезон амброзии — только в помещении или после 20:00 (раздел 12.1)
Признаки правильного выполнения	По окончании прогулки: дыхание носовое, разговор возможен фразами, КП через 10 минут после — не ниже утренней

5. Трек А «Классический»

Состав: 4 сессии по 15–20 минут в день. Ориентирован на максимальную скорость роста КП.

5.1. Расписание дня (пример, привязанный к вашему рабочему графику)

Слот	Время (ориентир)	Что	Длительность	Условие
Пробуждение	07:00	КП утренняя, ПСВ, дневник	7 мин	До подъёма, до препаратов
Утро	07:10	Гигиена носа + Нозефрин + базис по назначению	по схеме	—
Завтрак	07:40	Приём пищи	—	—

Слот	Время (ориентир)	Что	Длительность	Условие
Сессия 1	09:30–09:50	Полная сессия	20 мин	≥ 1,5–2 ч после еды
Работа	10:00–13:00	Клиентские сессии + Т-7 между ними	2 мин × N	—
Обед	13:00	Приём пищи	—	—
Сессия 2	15:00–15:20	Полная сессия	20 мин	≥ 2 ч после обеда
Работа	15:30–18:30	Клиентские сессии + Т-7	2 мин × N	—
Сессия 3	18:45–19:00	Сокращённая сессия	15 мин	До ужина или ≥ 2 ч после
Ужин	19:30	Приём пищи, лёгкий	—	Не позднее 3 ч до сна
Ходьба	20:15	Т-8, носовое дыхание	20–40 мин	Раздел 12.3
Сессия 4	22:00–22:15	Вечерняя, без задержек	15 мин	≥ 2 ч после ужина, ≥ 1 ч до сна
Отход ко сну	23:00	Т-6 в постели, вечерняя КП	10–15 мин	—

Итого: 70 минут структурированной практики + микро-восстановления.

5.2. Состав сессий

Сессия 1 (утро, полная, 20 мин) — основная нагрузочная:

Блок	Время	Содержание
1	2 мин	Т-1 базовая позиция и наблюдение
2	1 мин	КП «до», запись
3	4 мин	Т-2 уменьшенное дыхание, цикл 1 (3 мин работа + 1 мин отдых)
4	4 мин	Т-2, цикл 2
5	2 мин	Т-3 малые паузы, 2 подхода
6	4 мин	Т-2, цикл 3
7	2 мин	Свободное носовое дыхание, выход
8	1 мин	КП «после», запись

Сессия 2 (день, полная, 20 мин): структура идентична сессии 1. С недели 5 — в блок 5 вместо Т-3 вводится Т-4 (контролируемая задержка, 3–5 повторов).

Сессия 3 (вечер, сокращённая, 15 мин):

Блок	Время	Содержание
1	2 мин	Т-1
2	1 мин	КП «до»
3	4 мин	Т-2, цикл 1
4	4 мин	Т-2, цикл 2
5	2 мин	Т-3 малые паузы
6	2 мин	Выход, КП «после»

Сессия 4 (поздний вечер, 15 мин) — только успокаивающая:

Блок	Время	Содержание
1	3 мин	Т-1, свет приглушён
2	10 мин	Т-2 интенсивности 1–2, без задержек, без КП «до»
3	2 мин	Переход к Т-6 в постели

Задержки и высокая интенсивность в сессии 4 запрещены — это прямой путь к нарушению засыпания.

5.3. Пропуски в треке А

Ситуация	Правило
Пропущена 1 сессия	Не наверстывать. Дневник: «Сессий_выполнено» = 3
Пропущены 2 сессии	Обязательно выполнить утреннюю и вечернюю (1 и 4)
Выполнено < 3 сессий 3 дня подряд	Переход на трек В (раздел 7)
Минимум для зачёта дня	2 сессии, одна из которых — утренняя

6. Трек В «Компактный»

Состав: 2 сессии по 10–12 минут + 3–4 микропрактики. Ориентирован на встраиваемость в плотный рабочий день. Общий объём меньше, скорость роста КП ниже примерно на четверть, но приверженность выше — и по итогу результаты часто сопоставимы.

6.1. Расписание дня

Слот	Время	Что	Длительность
Пробуждение	07:00	КП, ПСВ, дневник	7 мин
Утро	07:10	Гигиена носа, базис	по схеме
Завтрак	07:40	—	—

Слот	Время	Что	Длительность
Сессия 1	09:30–09:42	Полная компактная	12 мин
Микро-1	11:00	T-3, 10 малых пауз	2 мин
Обед	13:00	—	—
Микро-2	15:00	T-2, интенсивность 2	3 мин
Микро-3	17:00	T-3 + T-2	3 мин
Ходьба	19:30	T-8	20–40 мин
Микро-4	21:00	T-2, интенсивность 1–2	3 мин
Сессия 2	22:00–22:12	Вечерняя, без задержек	12 мин
Отход ко сну	23:00	T-6, вечерняя КП	10–15 мин

Плюс T-7 (1,5–2 мин) после каждой клиентской сессии — эти минуты в дневнике не считаются, но по факту дают ещё 10–15 минут работы в день.

Итого: ~35 минут структурированной практики + микропрактики + T-7.

6.2. Состав сессий

Сессия 1 (утро, 12 мин):

Блок	Время	Содержание
1	2 мин	T-1
2	1 мин	КП «до»
3	4 мин	T-2, цикл 1 (3+1)
4	4 мин	T-2, цикл 2 (3+1)
5	1 мин	КП «после»

С недели 5: в цикл 2 добавляется T-4 (3 повтора) вместо последней минуты.

Сессия 2 (вечер, 12 мин):

Блок	Время	Содержание
1	2 мин	T-1
2	8 мин	T-2 интенсивности 1–2, без задержек
3	2 мин	T-3 малые паузы, мягко, переход к T-6

Микропрактики (2–3 мин каждая): без КП, без задержек (кроме T-3), интенсивность 2. Смысл микропрактик — не тренировка, а **прерывание накопления избыточного дыхания в течение рабочего дня**. Ставьте будильники (раздел 10.2).

6.3. Пропуски в треке В

Ситуация	Правило
Пропущена микропрактика	Не наверстывать
Пропущена сессия 1 или 2	Наверстать в ближайшее допустимое окно того же дня; если не получилось — не наверстывать
Минимум для зачёта дня	1 сессия + 2 микропрактики
Выполнено < минимума 3 дня подряд	Разбор причин в follow-up; сокращение сессии до 8 минут вместо отказа от практики

7. Критерий выбора трека и правило перехода

7.1. Как выбрать — решение по таблице, а не по ощущению

Ответьте на 6 вопросов. Считайте баллы.

№	Вопрос	Ответ → баллы
1	Сколько дней в неделю у вас есть два свободных окна по 20 минут в рабочее время (не считая утра и вечера)?	5–7 дней → A: 2 ; 3–4 дня → A: 1 ; 0–2 дня → B: 2
2	Сколько клиентских сессий у вас в среднем в день?	≤ 3 → A: 1 ; 4–5 → B: 1 ; ≥ 6 → B: 2
3	Есть ли у вас опыт удержания ежедневной практики длительностью 60+ мин/день более месяца?	Да → A: 2 ; Нет → B: 1
4	Как вы реагируете на невыполненный план?	Спокойно, возвращаюсь → A: 1 ; Пропуск обесценивает всё дело → B: 2
5	Ваш приоритет на 8 недель	Максимальная скорость роста КП → A: 2 ; Гарантированная регулярность → B: 2
6	Утренняя КП стабильна (разброс за 7 дней ≤ 3 сек)? (оценивается на конец недели 1)	Да → A: 1 ; Нет / неизвестно → B: 1

Решение: сумма баллов A > сумма баллов B → трек A. Иначе → трек B. При равенстве — **трек B**.

Моя рекомендация по вашему профилю, если вы захотите её услышать до подсчёта: начать с **трека B на недели 1–2**. Причина не в вашей мотивации, а в фазе: первые две недели — это пик амброзии и период обучения технике, когда объём практики почти не влияет на результат, а качество исполнения влияет решающе. Разгоняться в это время незачем. Решение о переходе на A принимается 16.09.2026 по правилам ниже.

7.2. Правило перехода B → A

Переход разрешён при одновременном выполнении **всех** условий:

№	Условие
1	Пройдено ≥ 14 дней практики
2	Личный лучший ПСВ установлен; утренняя ПСВ $\geq 80\%$ в ≥ 12 из последних 14 дней
3	Ни одного срабатывания стоп-критериев за последние 10 дней
4	Приверженность: минимум для зачёта дня выполнен в ≥ 12 из 14 дней
5	Техника Т-2 выполняется без ошибок из списка (см. 4/Т-2) — самооценка по чек-листу, разброс КП «до/после» стабильно положительный (+2 сек и более в ≥ 5 из 7 последних сессий)
6	Засыпание ≤ 30 мин в ≥ 5 из 7 последних ночей

Порядок перехода: не резко. Неделя перехода: 3 сессии вместо 4 (убирается сессия 3). Через 7 дней при отсутствии срабатываний — полный трек А.

7.3. Правило перехода А → В (откат по объёму)

Переход **обязателен** при любом из:

№	Триггер
1	Выполнено < 3 сессий в день 3 дня подряд
2	Засыпание > 45 мин 3 ночи подряд (одновременно со снижением нагрузки по разделу 8.4)
3	Утренняя ПСВ $< 80\%$ два дня подряд
4	Утренняя КП снизилась на ≥ 4 сек относительно среднего за предыдущие 7 дней и держится 3 дня
5	Любое срабатывание стоп-критерия из раздела 2.3
6	Субъективное истощение от протокола: практика превратилась в источник напряжения (регистрируется по дневнику: «Самочувствие_0_10» ≤ 4 три дня подряд при отсутствии респираторных симптомов)

Порядок отката: немедленно, в тот же день. Возврат к А — только по правилам 7.2, не ранее чем через 7 дней.

7.4. Смешанный режим (разрешён)

В рабочие дни — трек В, в выходные — трек А. Это допустимо и не считается нарушением протокола. Единственное требование: **утренняя сессия и утренние замеры — ежедневно, вне зависимости от режима.**

8. Фазовый план 8 недель

8.1. Общая архитектура

Фаза	Недели	Даты	Название	Задача фазы	Ожидаемая КП на конец фазы
Ф1	1–2	02.09– 15.09	Установка и baseline	Освоить технику, набрать 14 дней ПСВ, запустить элиминацию аллергена. Прогрессии нет	19–21 (допустимо снижение)
Ф2	3–4	16.09– 29.09	Сезонное удержание	Удержать показатели на хвосте сезона, минимальные шаги прогрессии	21–23
Ф3	5–6	30.09– 13.10	Окно роста	Основной прирост КП, ввод Т-4, ввод кардио-прогрессии	25–27
Ф4	7–8	14.10– 27.10	Консолидация и выход на цель	Выход на 30 сек, стабилизация, оценка итога	28–32

Ключевое: недели 1–4 — это не «медленный старт из осторожности». Это единственный корректный способ работать в пик амброзии. Рост КП на фоне активного аллергического воспаления либо не идёт, либо идёт за счёт волевого терпения — то есть является ложным. На второй-третьей неделе у большинства пациентов в сезон КП стоит или проседает на 1–3 секунды, и это ожидаемая часть плана, а не признак того, что метод не работает у вас.

8.2. Детализация по неделям

Нед.	Даты	Трек / объём	Техники	Задержки	Контрольные точки конца недели
1	02.09– 08.09	В, сессии по 10 мин, 2 микро	Т-1, Т-2 (инт. 2, циклы 3+1), Т-3, Т-5 по потребности, Т-6	Только Т-3 (2–4 сек). Т-4 запрещена	ПСВ 2×/сут — 7/7 дней. ЧД baseline снят. АСТ записан. Элиминация аллергена развёрнута полностью
2	09.09– 15.09	В, сессии 12 мин, 3 микро	+ расширение амплитуды диафрагмы до умеренной (при отсутствии реакций по ЖКБ)	Т-3 (до 5 сек)	Личный лучший ПСВ установлен (сезонный ориентир). Зоны рассчитаны. Решение по треку (раздел 7.1)
3	16.09– 22.09	В или А по решению	+ Т-8 ходьба 20 мин	Т-3. Т-4 по-прежнему запрещена	Первый шаг прогрессии по правилу 8.3 разрешён с 16.09

Нед.	Даты	Трек / объём	Техники	Задержки	Контрольные точки конца недели
4	23.09– 29.09	Текущий трек, полный объём	Полный набор без Т-4	Т-3	Плановая точка follow-up. АСТ повторно. Итог сезонной фазы
5	30.09– 06.10	Целевой трек, полный объём	+ Т-4 (ввод) , Т-8 30 мин	Т-4: 3 повтора, ≤ 50 % от КП, 1 раз в день	Пересчёт личного лучшего ПСВ начат. Оценка переносимости Т-4
6	07.10– 13.10	Полный объём + прогрессия	Т-4: 4–5 повторов, ≤ 60 % от КП	Т-4 в 2 сессиях в день	Пересчёт личного лучшего ПСВ завершён, зоны обновлены
7	14.10– 20.10	Максимальный объём фазы	Т-2 циклы по 5 мин, Т-8 40 мин	Т-4 ≤ 60 % КП. Максимальная пауза — не более 1 раза за неделю, ≤ 90 % КП, только при ПСВ ≥ 90 %	Проверка стабильности КП (правило 3.1)
8	21.10– 27.10	Удержание, без наращивания	Полный набор	Как на неделе 7	Итоговая точка: КП, ПСВ, АСТ, ЧД, тест «5-й этаж», недельная сводка

8.3. Правило повышения нагрузки (явное, измеримое)

Прогрессия — это увеличение **одного** параметра за раз. Никогда двух.

Ступени прогрессии (порядок фиксирован):

Ступень	Что увеличивается	Шаг
П-1	Длительность цикла Т-2	+1 мин к рабочей части цикла (3 → 4 → 5 мин, потолок 5 мин)
П-2	Количество циклов Т-2 в сессии	+1 цикл (2 → 3 → 4 → 5, потолок 5)
П-3	Количество сессий в день	+1 (только в рамках перехода В → А)
П-4	Интенсивность воздушного голода	2 → 2–3 (только с недели 5, потолок 3)
П-5	Длительность Т-3	2–3 сек → 4–5 сек (потолок 5 сек)
П-6	Ввод и наращивание Т-4	Только с недели 5, 50 % → 60 % от КП (потолок 60 %)

Условия разрешения шага прогрессии (выполняются ВСЕ):

№	Условие	Проверка
1	Прошло ≥ 5 дней с предыдущего шага	Дневник
2	Текущая дата $\geq 16.09.2026$ (baseline ПСВ накоплен)	Календарь
3	Утренняя ПСВ $\geq 80\%$ от личного лучшего все последние 5 дней	Дневник, колонка «Зона_ПСВ»
4	Ни одного срабатывания стоп-критериев за последние 5 дней	Дневник
5	КДБА не применялся ≥ 7 дней	Колонка «КДБА_применён»
6	Засыпание ≤ 40 мин в ≥ 4 из последних 5 ночей	Колонка «Засыпание_мин»
7	Приверженность $\geq 80\%$ (минимум для зачёта дня выполнен в 4 из 5 дней)	Колонка «Сессий_выполнено»
8	КП «после сессии» превышает КП «до сессии» на ≥ 2 сек в ≥ 4 из последних 5 сессий	Дневник

Если хотя бы одно условие не выполнено — **шаг не делается**, текущий уровень удерживается ещё 5 дней, затем проверка повторяется.

8.4. Правило отката (явное, измеримое)

Триггер отката	Величина отката
Утренняя ПСВ в жёлтой зоне (60–79 %) 1 день	Прогрессия стоп. Уровень удерживается. ПСВ 2×/сут
Утренняя ПСВ в жёлтой зоне 2 дня подряд	Откат на один шаг назад по последней ступени
Утренняя ПСВ в жёлтой зоне 4 дня из 7	Откат на два шага , переход на трек В, follow-up
Утренняя ПСВ в красной зоне ($< 60\%$)	Полная остановка программы , КДБА, врач
КП снизилась на ≥ 4 сек от среднего за 7 дней, 2 дня подряд	Откат на один шаг
Засыпание > 45 мин 3 ночи подряд	Откат на один шаг и отмена задержек Т-4 на 5 дней и перенос вечерней сессии на ≥ 3 ч до сна
Любой стоп-критерий раздела 2.3	По алгоритму 2.4 + возврат по 2.6
Пропуск ≥ 3 дней практики подряд	Откат на уровень предыдущей недели, 3 дня удержания

Триггер отката	Величина отката
Появление или усиление симптомов пыльцевой аллергии («Пыльца_симптомы_0_10» ≥ 7 два дня подряд)	Прогрессия стоп, усиление блока 12.1, практика — редуцированный объём

После любого отката прогрессия возобновляется только по правилу 2.6 (48 ч + 3 дня зелёной зоны + 3 дня удержания на каждой ступени).

8.5. Редуцированный объём (единый «щадящий режим»)

Применяется при: ПСВ в жёлтой зоне, пыльцевом пике, после срабатывания стоп-критерия, при ОРВИ без температуры, в первые 2 дня после возврата к практике.

Что включено	Что исключено
T-1 (2 мин)	T-4 полностью
T-2, интенсивность 1–2 , 2 цикла по 2 мин	Максимальная пауза
T-3, паузы ≤ 3 сек	T-8 в аллергенной среде (улица в пыльцевой день)
T-5 по потребности	Любая прогрессия
T-6 вечером	Наращивание чего-либо
T-7 между клиентами	—
Утренние КП и ПСВ — обязательно	—

Итого 8–10 минут в день. Это не «пропуск» — это отдельный режим, который в дневнике фиксируется как «Сессий_выполнено = R» (см. правила заполнения, раздел 13).

8.6. Обработка плато

Определение плато: утренняя КП не увеличилась ни на секунду относительно среднего за предыдущие 10 дней — в течение **10 дней подряд**, при этом фаза — Ф3 или Ф4 (в Ф1–Ф2 плато нормально и вмешательства не требует).

Алгоритм при плато — по шагам, в этом порядке:

Шаг	Что проверяем	Действие
1	Ночное дыхание. Сухость во рту утром есть? Храп сохраняется?	Если да — причина плато почти наверняка здесь. Усиление раздела 9: позиционная терапия строго, гигиена спальни, приподнятое изголовье. Никакого наращивания дневной нагрузки
2	Техника. Не превратилось ли T-2 в задержки/урежение с глубокими вдохами?	Неделя работы на интенсивности 1–2 с акцентом на пассивный выдох. Парадоксально, но снижение интенсивности при плато чаще помогает, чем повышение

Шаг	Что проверяем	Действие
3	Аэробная нагрузка. Т-8 выполняется? Сколько минут в неделю?	Если < 120 мин/нед — увеличить до 150–180 мин/нед носовой ходьбы. Это самый частый работающий рычаг на плато 24–27 сек
4	Дневной фон. Сколько часов в день вы говорите? Есть ли Т-7 после каждой сессии?	Добавить 2 микропрактики, усилить дневной чек-лист (раздел 10)
5	Аллерген / воспаление. Симптомы риносинусита, ПСВ, вариабельность	Пересмотр блока 12.1. Если ПСВ вариабельна > 15 % — плато функциональное, форсировать нельзя
6	Сон, вес, еда. Позднее время отхода ко сну, поздний ужин, вес	Раздел 12.4–12.6
7	Если шаги 1–6 отработаны, а плато держится ещё 7 дней	Разгрузочная неделя: объём практики снижается на 40 % (сохраняются утренняя сессия + вечерняя), задержки Т-4 отменяются, замеры продолжаются. У значительной части людей КП прибавляет именно на разгрузке
8	Плато сохраняется после разгрузочной недели	Follow-up с полным пакетом данных. Цель курса пересматривается по срокам, но не по величине

Отдельно — что при плато делать запрещено: увеличивать интенсивность воздушного голода выше 3, добавлять максимальные паузы, увеличивать количество сессий сверх трека А, «пробовать выжать КП» волевым терпением. Все эти действия дают рост цифры на 2–3 дня с последующим падением ниже исходного уровня и повышают риск бронхоспазма.

Конец Части 1. Часть 2 — разделы 9–16 — ниже.

Часть 2 — разделы 9–16

9. Ночной компонент

9.1. Оценка допустимости заклеивания рта на ночь — решение

Раздел написан протокольно.

Решение: заклеивание рта на ночь на старте программы **ЗАПРЕЩЕНО**. Запрет действует до выполнения условий пункта 9.3 в полном объёме.

Обоснование, по пунктам:

1. **Сильный храп при ИМТ 27 и возрасте 48 лет — состояние, при котором СОАС (синдром обструктивного апноэ сна) должен считаться вероятным, пока не исключён объективно.** Отсутствие свидетельских наблюдений остановок дыхания и субъективное ощущение отдохнувшего пробуждения не исключают СОАС: значительная часть пациентов с подтверждённым апноэ не имеет ни того, ни другого признака.
2. При обструктивных событиях во сне ротовое дыхание может быть **компенсаторным путём** — то есть тем каналом, через который восстанавливается вентиляция после эпизода закрытия глотки. Механическое перекрытие рта в этой ситуации потенциально удлиняет эпизоды десатурации (падения насыщения крови кислородом).
3. **Бронхиальная астма.** При ночном бронхоспазме потребность в ротовом дыхании физиологически возрастает. Перекрытый рот в момент ночного ухудшения — фактор, увеличивающий тяжесть эпизода и задерживающий пробуждение и применение КДБА.
4. **Пик сезона амброзии на неделях 1–4.** Ночная заложенность носа в этот период может возникать внезапно и полностью. Заклеенный рот при полностью заложенном носе — недопустимая ситуация.
5. **Полисомнография и респираторный мониторинг не проводились.** Объективных данных о ночном дыхании нет вообще.

Совокупность пунктов 1–5 делает риск неприемлемым при отсутствии верификации. Это не осторожность формулировки — это запрет.

9.2. Что делаем вместо этого на неделях 1–8 (работает со вторичной целью №1)

Сухость во рту утром — прямое следствие ротового дыхания во сне. Убирать её будем без пластыря:

№	Мера	Как выполнять	Обоснование
Н-1	Носовая проходимость к моменту засыпания	За 30–40 мин до сна: промывание носа солевым раствором → Нозефрин по назначенной схеме → при остаточной заложенности Т-5 (носовая разблокировка), 3–6 подходов	Ротовое дыхание ночью начинается там, где нос не проходит
Н-2	Вход в сон на носовом дыхании	Т-6, 10–15 мин, лёжа на боку, губы сомкнуты, язык на нёбе	Дыхательный паттерн первых 20 минут сна во многом задаёт паттерн ночи
Н-3	Позиционная терапия	Раздел 9.5	Прямое снижение храпа
Н-4	Приподнятое изголовье	Головной конец кровати выше на 10–15 см (подложить под ножки, а не громоздить подушки — подушки сгибают шею и ухудшают проходимость глотки)	Снижение храпа и ночного заброса содержимого

№	Мера	Как выполнять	Обоснование
Н-5	Дневная тренировка носового дыхания	Т-8 ходьба с закрытым ртом, Т-7 после клиентских сессий, дневной чек-лист (раздел 10)	Ночное дыхание — производное дневного паттерна
Н-6	Увлажнение воздуха в спальне	Влажность 40–50 %, гигрометр. Не выше — иначе растёт нагрузка по клещу домашней пыли и плесени	Сухой воздух сам по себе даёт сухость во рту и утром, и провоцирует ротовое дыхание
Н-7	Отказ от алкоголя и седативных перед сном	Полностью, весь курс	Снижают тонус мышц глотки, усиливают храп и обструкцию
Н-8	Последний приём пищи ≥ 3 часов до сна	Раздел 12.6	Полный желудок усиливает храп; плюс режим по ЖКБ

Измеримый критерий эффективности: «Сухость_рта_утром» = Нет в ≥ 5 из 7 ночей к концу недели 4 и в 7 из 7 к концу недели 8. Если к концу недели 4 показатель не улучшился — это дополнительный аргумент за респираторный мониторинг сна (раздел 15.2).

9.3. Условия, при которых заклеивание рта может быть начато

Раздел написан протокольно.

Пластырь может быть введён в программу **только после одновременного выполнения всех девяти условий**. Отсутствие любого из них — запрет сохраняется.

№	Условие	Способ подтверждения
У-1	Проведён респираторный мониторинг сна или полисомнография, и в заключении специалиста апноэ сна не выявлено либо указано, что клинически значимых нарушений дыхания во сне нет	Заключение на руках
У-2	Текущая дата вне пика сезона амброзии (не ранее 01.10.2026)	Календарь
У-3	Носовое дыхание свободно вечером и ночью 14 ночей подряд , без эпизодов заложенности	Дневник, «Заметки»
У-4	Утренняя ПСВ ≥ 80 % от личного лучшего 14 дней подряд	Дневник, «Зона_ПСВ»
У-5	КДБА не применялся 14 дней подряд	«КДБА_применён»
У-6	Ночных симптомов (кашель, свист, стеснение в груди, пробуждение от нехватки воздуха) нет 14 ночей подряд	«Ночные_симптомы»
У-7	Утренняя КП ≥ 25 сек, стабильно (разброс за 7 дней ≤ 4 сек)	Дневник

№	Условие	Способ подтверждения
у-8	Пройдена дневная проба (пункт 9.4, шаг 1–2) без единого затруднения	Дневник
у-9	В квартире ночью присутствует взрослый человек, оповещённый о том, что вы используете пластырь	—

Практический прогноз по вашему курсу: при честном выполнении этих условий пластырь в рамках 8 недель реалистичен не ранее недели 6–7 и только при том, что исследование сна будет проведено в сентябре. Если исследование не проведено — пластырь не вводится вообще, и это не мешает достижению цели курса: ночную сухость мы убираем мерами Н-1 – Н-8 и позиционной терапией, а они в вашем случае дают основную часть эффекта.

9.4. Техника безопасности при вводе пластыря (если условия выполнены)

Шаг	Содержание	Длительность
1	Дневная проба. Пластырь наклеивается днём, в бодрствовании, в покое, 60 минут. Оценка: сохраняется ли свободное носовое дыхание, нет ли нарастающей тревоги	3 дня подряд
2	Вечерняя проба. Пластырь наклеивается за 30 минут до сна, в бодрствовании, снимается перед засыпанием	3 вечера подряд
3	Первая ночь. Только после успешных шагов 1–2. Рядом — телефон, вода, КДБА на тумбочке	1 ночь, затем оценка
4	Расширение. При отсутствии критериев отмены — 2 ночи, затем 4, затем ежедневно	2 недели

Требования к исполнению:

№	Требование
1	Используется гипоаллергенный пластырь, предназначенный для кожи. Строительный, канцелярский, широкий тканевый скотч — запрещены
2	Рот не перекрывается полностью . Наклеивается одна вертикальная полоска по центру губ, оставляющая свободными углы рта. Задача — механическое напоминание, а не герметизация
3	Пластырь должен сниматься одним движением, без поиска края. Край подворачивается заранее
4	Не применяется: при заложенности носа любой степени; при тошноте; при алкоголе или седативных средствах накануне; при ОРВИ; при любых симптомах астмы в этот день; при ПСВ < 80 %

№ Требование

5 Не применяется в первую ночь после смены дозы или схемы любого препарата

9.5. Критерии немедленной отмены пластыря

Отмена **навсегда в рамках этого курса**, без попытки повторного ввода, при любом из:

- пробуждение с нехваткой воздуха, удушьем или паникой;
- пробуждение с сорванным пластырем — 2 ночи из 5;
- ночной кашель или свистящее дыхание, которых не было до ввода;
- утренняя ПСВ снизилась на $\geq 10\%$ от личного лучшего в первые 3 ночи применения;
- утренняя КП снизилась на ≥ 3 сек относительно среднего за 7 дней до ввода;
- засыпание > 45 минут 3 ночи подряд;
- усиление храпа по отзыву;
- любое применение КДБА в ночь или утро после применения пластыря.

9.6. Позиционная терапия сна

Здесь эффект прогнозируем и достигим уже на первой неделе. Для вашего профиля (ИМТ 27, сильный храп) это самая результативная ночная мера из доступных без обследования.

№	Мера	Как выполнять	Обоснование в вашем профиле
П-1	Исключить положение на спине	Основное целевое положение — на боку, предпочтительно левом . На животе допустимо, если удобно шее	В положении на спине корень языка и мягкие ткани глотки смещаются назад — это основной механизм храпа и обструктивных эпизодов. На правом боку не спим — по режиму ЖКБ
П-2	Механический ограничитель	В карман, пришитый на спине ночной футболки между лопаток, помещается теннисный мяч или туго свёрнутый носок. Возврат на спину становится некомфортным и прерывается без пробуждения	Самый простой рабочий способ. Носится минимум 3 недели — за этот срок положение обычно закрепляется
П-3	Подушка	Высота подушки такая, чтобы в положении на боку линия «затылок — шея — грудной отдел» была прямой. Проверка: попросить сфотографировать вас сбоку в позе сна	Высокая подушка сгибает шею и сужает просвет глотки — усиливает храп. Низкая даёт запрокидывание

№	Мера	Как выполнять	Обоснование в вашем профиле
П-4	Приподнятое изголовье	Головной конец кровати выше на 10–15 см за счёт подставок под ножки. Не за счёт подушек	Уменьшает храп и ночную заложенность носа
П-5	Отслеживание результата	Колонка «Храп_по_отзыву» — ежедневно; при отсутствии свидетеля — запись на диктофон телефона (любое приложение с записью по звуку), 2 ночи в неделю	Без объективизации мы не поймём, работает ли мера

Измеримые критерии эффективности позиционной терапии:

Показатель	Точка контроля	Целевое значение
Ночей на спине (по ощущению при пробуждении / записи)	Конец недели 2	≤ 1 из 7
«Храп_по_отзыву» = «сильный»	Конец недели 4	≤ 2 из 7 ночей
«Сухость_рта_утром» = «Да»	Конец недели 4	≤ 2 из 7
«Сухость_рта_утром» = «Да»	Конец недели 8	0 из 7

Если к концу недели 4 «Сухость_рта_утром» держится в ≥ 4 из 7 ночей при полном выполнении П-1 – П-4 — это значимый аргумент за респираторный мониторинг сна и повод для внепланового follow-up (раздел 14).

10. Дневной контроль

Дневной фон важнее сессий. Сорок минут корректного дыхания в сессиях не перевесят двенадцати часов избыточного дыхания в остальное время — а у вас эти двенадцать часов включают многочасовую речевую нагрузку. Поэтому этот раздел по весу равен разделам 5–6.

10.1. Чек-лист контроля дыхания в быту

Проверяется в момент срабатывания напоминания, 15–20 секунд.

№	Пункт	Норма	Коррекция при отклонении
1	Рот закрыт	Губы сомкнуты, язык лежит на нёбе за верхними зубами	Закрыть рот, язык на нёбо
2	Дыхание носовое	Да	При заложенности — Т-5

№	Пункт	Норма	Коррекция при отклонении
3	Дыхание слышно?	Нет. Своё дыхание в тишине не слышно	30 сек уменьшенного дыхания
4	Дышу ли я плечами?	Плечи и ключицы неподвижны	Опустить плечи, вернуть опору на спинку
5	Челюсть	Зубы разомкнуты, жевательные мышцы не напряжены	Разомкнуть, выдох-отпускание
6	Поза	Таз нагружен равномерно, спина имеет опору, живот не поджат	Перестроить посадку
7	Были ли за последний час глубокие вздохи, зевки с полным вдохом, «добор» воздуха?	Нет	См. правило 10.3
8	Дыхание через рот при разговоре	Нет: вдох между фразами — носом	Микротехника М-2 (10.4)

Отдельно и постоянно, вне напоминаний:

- вдох носом при физической нагрузке любой интенсивности, включая подъём по лестнице и перенос сумок;
- не разговаривать на вдохе;
- не дышать ртом при еде, при чтении, при работе за компьютером;
- не спать на спине.

10.2. Четыре напоминания

Ставятся в телефоне как повторяющиеся будильники с тихим сигналом. Время подобрано под ваш график — сдвиньте под реальный, но сохраните привязку к событиям.

№	Время	Привязка к событию	Что делаю	Длительность
P-1	11:00	Середина утреннего блока клиентов	Чек-лист 10.1 + Т-3 (10 малых пауз)	2 мин
P-2	15:00	Через 2 ч после обеда	Чек-лист + Т-2, интенсивность 2	3 мин
P-3	17:00	Пик накопленной речевой нагрузки	Чек-лист + Т-7	3 мин
P-4	21:00	За 2 ч до сна, «переключение»	Чек-лист + Т-2 интенсивности 1–2, без задержек	3 мин

В треке В эти четыре точки — и есть микропрактики. В треке А они дополняют сессии и выполняются в сокращённом виде (только чек-лист + 30–60 сек уменьшенного дыхания).

Критерий выполнения: ≥ 3 из 4 напоминаний отработаны в ≥ 5 днях из 7. Ниже — это фактор, который надо разбирать при плато (раздел 8.6, шаг 4).

10.3. Правило «поймала себя на вздохе»

Триггеры правила: глубокий вздох; зевок с полным вдохом; «добор» воздуха посреди фразы; вдох ртом; ощущение, что «не хватило воздуха»; кашлевой позыв на вдохе.

Действие — единый протокол, 30 секунд:

Шаг	Действие	Время
1	Закрыть рот. Не делать компенсаторный глубокий вдох «до конца» — именно он запускает следующий вздох через 2–3 минуты	сразу
2	Проглотить слюну или задержать дыхание на 2–3 секунды после выдоха — это гасит рефлекс вздоха	3 сек
3	30 секунд уменьшенного дыхания , интенсивность 2, выдох пассивный	30 сек
4	Вернуться к обычному носовому дыханию, не форсируя	—

Если вздохи идут сериями (≥ 3 вздохов за 10 минут): это не повод усиливать контроль. Это сигнал одного из трёх: (а) вы работаете на слишком высокой интенсивности в сессиях, (б) нарастает аллергическая нагрузка, (в) поднимается эмоциональная активация (раздел 11). Действие: 3 минуты уменьшенного дыхания интенсивности 1–2, замер ПСВ, отметка в «Заметки». Если серии вздохов повторяются ≥ 3 дней — прогрессия останавливается до выяснения причины.

10.4. Микротехники для клиентских сессий

Специфика: вы говорите долго, находитесь в контакте, и не можете в этот момент заниматься собственным дыханием как задачей. Поэтому всё, что ниже, встроено в речь и слушание и не требует ни счёта, ни отвлечения внимания.

Код	Техника	Как выполняется	Когда
М-1	Носовой вдох при слушании	Пока говорит клиент — рот закрыт, язык на нёбе, дыхание носом, плечи опущены. Ничего не регулируете, кроме закрытого рта	Постоянно, всё время слушания. Это основная мера — на неё приходится большая часть эффекта
М-2	Вдох носом между фразами	Не добирать воздух ртом посреди фразы. Закончили фразу — короткий носовой вдох — следующая фраза	При каждой своей реплике
М-3	Речь на «хвосте» выдоха	Начинать фразу не на пике вдоха, а спустя мгновение, когда выдох уже начался. Фраза при этом сама укорачивается — говорите короче и с паузами	При длинных высказываниях

Код	Техника	Как выполняется	Когда
М-4	Пауза-точка	В естественных паузах разговора (клиент думает, молчание в контакте) — не заполнять паузу дыханием: рот закрыт, один спокойный выдох, короткая пауза после него	3–5 раз за сессию
М-5	Микровозврат при вздохе	Поймали себя на вздохе в контакте — не делать протокол 10.3 целиком (он потребует ухода из контакта). Сделать шаги 1–2: закрыть рот, глотнуть, пауза 2–3 сек. Полный протокол — после сессии	По факту
М-6	Вода мелкими глотками	Стакан воды рядом; глоток при первом ощущении сухости во рту. Сухость во рту в течение дня — маркёр ротового дыхания или его эпизодов	По потребности

Правило восстановления дыхания между сессиями — обязательное:

Шаг	Действие	Время
1	Клиент вышел — молчание. Не говорить, не звонить, не отвечать голосовыми сообщениями	—
2	T-7: 60–90 сек уменьшенного дыхания интенсивности 2	1,5 мин
3	3 малые паузы (T-3)	30 сек
4	Вода, при необходимости — промывание носа в сезон	—

Итого 2 минуты между сессиями. Если перерыв между клиентами меньше 5 минут — выполняется только шаг 2 в объёме 60 секунд. Если сессии идут подряд без перерыва — это отдельная проблема для программы: при ≥ 4 сессиях подряд без перерывов дневная гипервентиляция гарантированно перекроет эффект утренней практики. Минимальное требование протокола: **перерыв 10 минут после каждого двух клиентских сессий.**

Измеримый критерий по дневному блоку:

Показатель	Как считать	Целевое значение к неделе 4	К неделе 8
T-7 после клиентских сессий	Доля сессий, после которых выполнено	$\geq 60 \%$	$\geq 85 \%$
Эпизоды ротового дыхания, замеченные за день	Отметка в «Заметки» числом	≤ 5	≤ 2
Сухость во рту днём	Балл 0–10 в «Заметки»	≤ 3	≤ 1

11. Дифференциация феноменов

Уменьшенное дыхание и задержки закономерно поднимают телесный и эмоциональный материал. Вам этот пласт знаком профессионально; моя задача — не объяснять его, а дать разметку, по которой вы **внутри дыхательного протокола** принимаете решение: продолжать, снизить, остановить. Разметка рабочая и предназначена для принятия решения за 5–10 секунд, а не для анализа.

11.1. Три категории — сравнительная таблица

Признак	А. Физиология уменьшенного дыхания	Б. Тревожная реакция на задержку	В. Эмоциональный материал
Момент появления	Через 1,5–4 мин от начала цикла, нарастает плавно	В первые секунды задержки или до её начала, в момент решения задержать дыхание	В любой момент, чаще во второй половине сессии или на фазе покоя после цикла
Динамика	Нарастает и стабилизируется на плато; предсказуема, воспроизводится от сессии к сессии	Нарастает лавинообразно, ускоряясь; ощущение, что «сейчас станет хуже»	Волнообразная, не связана с фазой дыхания
Локализация	Диафрагма, нижние рёбра, диффузное тепло в кистях, стопах, лице	Верхняя грудная клетка, горло, «сжатие» под ключицами, сердцебиение, холод в кистях	Часто вне дыхательного контура: горло, глаза, челюсть, живот, поясница, тазовая область; может быть асимметрична
Типичные проявления	Тепло, испарина на лбу и спине, повышенное слюноотделение, зевота, лёгкое покраснение лица, желание вдохнуть глубже, урчание в животе, позыв к мочеиспусканию после сессии	Учащение и углубление дыхания, напряжение шеи и плеч, мысль «не хватит воздуха», желание немедленно открыть рот, ощущение нереальности, сердцебиение с ускорением	Слёзы, ком в горле, дрожь, жар или озноб волной, всплывающий образ/воспоминание/сцена, внезапная тоска, злость, стыд, смех
Реакция на снижение интенсивности до 1	Уходит за 30–60 сек, полностью	Снижается частично, остаточное напряжение и	Не зависит от интенсивности дыхания;

Признак	А. Физиология уменьшенного дыхания	Б. Тревожная реакция на задержку	В. Эмоциональный материал
		настороженность держатся минуты	продолжается своим ходом
Реакция на возобновление свободного дыхания	Проходит бесследно за 1–2 минуты	Проходит, но остаётся ожидание повторения при следующей задержке	Может усилиться, когда дыхание освобождается
Что происходит с КП «после сессии»	Выше, чем «до», на 2– 5 сек	Ниже, чем «до», либо нестабильна	Может быть любой; корреляции нет
Что происходит с ПСВ	Не меняется	Не меняется	Не меняется
Воспроизводимость	Высокая: те же ощущения в тех же фазах	Привязана к задержкам, а не к уменьшенному дыханию	Разовая или эпизодическая, содержание меняется

11.2. Что делать — по категориям

А. Физиология уменьшенного дыхания.

Ситуация	Действие по протоколу
Тепло, испарина, слюноотделение, зевота, умеренный воздушный голод (интенсивность 2)	Продолжать. Это признаки корректного выполнения. Довести цикл до конца
Воздушный голод дошёл до интенсивности 3 и держится	Снизить до 2 в пределах текущего цикла, не прерывая
Интенсивность 4: включились мышцы шеи, требуется терпеть	Прервать цикл, 1 минута свободного носового дыхания, продолжить со сниженной интенсивностью
Онемение пальцев, покалывание вокруг рта, сдавление головы (Д-2)	Остановить сессию. 3 минуты свободного дыхания. Следующая сессия — на шаг ниже
Головокружение	Стоп-критерий раздела 2.3. Сессия прекращается. Алгоритм 2.4
Кашель или свист	Стоп-критерий. Сессия прекращается немедленно. Алгоритм 2.4
Запись	«Заметки»: категория А, что именно, на какой минуте

Б. Тревожная реакция на задержку.

Отдельный, самый важный для протокола случай: тревога на задержку **не является поводом «преодолевать»**. Повторное преодоление закрепляет реакцию.

Шаг	Действие
1	Прекратить задержку немедленно, не доводя. Вдох носом, обычного объёма
2	60–90 секунд уменьшенного дыхания интенсивности 1 с опорой на выдох. Не считать, не измерять
3	В этой сессии задержки не возобновляются. Сессия дорабатывается в формате T-2 + T-3
4	На следующие 5 дней : из программы исключаются T-4 и КП «до сессии». Утренняя КП сохраняется — она единственная и делается не как испытание, а как замер
5	Возврат задержек: через 5 дней, с длительности 50 % от предыдущей рабочей , наращивание по правилу 8.3
6	Если тревога на задержку возникает повторно после возврата — T-4 исключается из программы до конца курса . Рост КП обеспечивается уменьшенным дыханием, ходьбой и ночным компонентом. Это рабочий сценарий, а не ограничение результата
7	Запись

Отдельно: если тревога возникает при мысли о предстоящем замере КП — замер выполняется, но с изменением условий: без секундомера в поле зрения (секундомер запускается и кладётся экраном вниз), длительность считывается после. Это снимает «эффект гонки».

В. Эмоциональный материал.

Шаг	Действие по протоколу дыхательной программы
1	Технику остановить. Уменьшенное дыхание, задержки, счёт, контроль — прекращаются полностью
2	Перейти на свободное носовое дыхание. Не углублять его специально, но и не сдерживать
3	Дать процессу идти столько, сколько он идёт. Никаких дыхательных инструкций в это время не выполнять — ни моих, ни собственных
4	Сессия в этот день не возобновляется . Она считается выполненной (в дневнике — фактическое число завершённых блоков)
5	Замер КП после этого не производится и в статистику не идёт: цифра будет невалидной
6	Следующая сессия — по расписанию, на том же уровне нагрузки. Откат не требуется: это не признак передозировки
7	Запись
8	Если категория В возникает ≥ 3 раз за 7 дней

11.3. Граница программы

Формулирую прямо, чтобы не было двусмысленности.

- **Моя зона:** параметры дыхания, дозировка, безопасность, объективные показатели, решение «продолжать / снизить / остановить». Я работаю с тем, **как** вы дышите, и с последствиями этого для бронхов, сна и КП.
- **Не моя зона:** содержание эмоционального материала, его происхождение, смысл и проработка. Я не интерпретирую его, не связываю с вашей биографией и не встраиваю в дыхательный протокол. Дыхательная программа не является и не становится методом работы с этим материалом.
- **Что мне нужно от вас как от участницы программы:** только формальные метки в дневнике — категория (А/Б/В), фаза сессии, влияние на выполнение и на замеры. Содержания я не запрашиваю и в follow-up не разбираю.
- **Практическое следствие:** если материал категории В делает выполнение сессий нерегулярным, я корректирую расписание и объём (перенос сессий, снижение интенсивности, исключение Т-4) — то есть подстраиваю дыхательную часть, а не пытаюсь работать с причиной.

12. Смежные блоки

12.1. Элиминация аллергена — фактор № 1 на недели 1–4

Почему это первый по важности блок именно у вас. Программа стартует 02.09.2026 в Краснодаре, в пике сезона амброзии. Аллергическое воспаление слизистой носа и бронхов напрямую снижает КП, повышает вариабельность ПСВ и провоцирует ночное ротовое дыхание. **Ни одна дыхательная техника не перевешивает эффект от снижения контакта с пылью.** На неделях 1–4 вклад этого блока в результат выше, чем вклад самих сессий. Запускается сегодня, до первой сессии.

Гигиена спальни

№	Мера	Как	Обоснование
Э-1	Спальня — зона без уличной одежды	Верхняя одежда, сумки, обувь в спальню не заносятся. Рабочая одежда снимается вне спальни	Пыльца переносится на текстиле и волосах
Э-2	Окна спальни закрыты в дневное время	Проветривание — по правилам Э-8	Основной путь поступления пыли в помещение
Э-3	Очиститель воздуха с HEPA-фильтром в спальне	Работает круглосуточно на неделях 1–4, ночью — на бесшумном режиме. Фильтр меняется по инструкции	Единственный способ снизить пылевую нагрузку при закрытых окнах
Э-4	Влажная уборка спальни	Ежедневно на неделях 1–4, далее 2–3 раза в неделю. Пол, подоконник, поверхности	Осевшая пыльца поднимается в воздух при движении
Э-5	Постельное бельё	Смена 1 раз в 3–4 дня на неделях 1–4, далее еженедельно. Стирка при 60 °С,	Бельё, высушенное на улице в сезон, — источник

№	Мера	Как	Обоснование
		сушка в помещении , не на улице и не на балконе	пыльцы прямо у лица на 8 часов
Э-6	Минимум пылесборников	Убрать из спальни ковры, лишний текстиль, мягкие игрушки, открытые полки с книгами. Шторы — стирающиеся, стирка раз в 2 недели в сезон	Снижает и пыльцевую, и клещевую нагрузку
Э-7	Влажность 40–50 %, гигрометр	Ниже — сухость слизистых и рта; выше — рост клеща и плесени	Влияет на цель «сухость во рту» напрямую

Проветривание

№	Правило
Э-8	Проветривать после дождя , ночью или ранним утром до 07:00 и поздним вечером после 22:00. Пыление амброзии максимально в первой половине дня в сухую ветреную погоду
Э-9	Во время проветривания — окно с натянутой влажной марлей или противопыльцевой сеткой; марля увлажняется заново каждый раз
Э-10	В сухую ветреную погоду днём окна не открывать вообще, включая рабочий кабинет
Э-11	В автомобиле — окна закрыты, режим рециркуляции, салонный фильтр заменён перед сезоном

Промывание носа

№	Параметр	Значение
Э-12	Раствор	Изотонический солевой раствор (аптечный спрей/душ или готовая система для промывания). Температура — комнатная или чуть теплее
Э-13	Частота на неделях 1–4	3 раза в день: утром после пробуждения, сразу по возвращении с улицы, вечером перед сном
Э-14	Частота на неделях 5–8	1–2 раза в день: утром и перед сном
Э-15	Порядок относительно Нозефрина	Сначала промывание, через 5–10 минут — Нозефрин. На очищенную слизистую препарат работает лучше; в обратном порядке вы его смываете
Э-16	Порядок относительно дыхательной сессии	Промывание → Нозефрин → 15 минут → при остаточной заложенности Т-5 → сессия
Э-17	Техника	Голова наклонена вперёд и вбок, рот открыт, дышать ртом во время процедуры, не глотать. После — не сморкаться резко и с силой , только мягко, по одной ноздре

Душ и одежда после улицы

№	Мера	Обоснование
Э-18	По возвращении с улицы: сменить одежду, вымыть голову или как минимум лицо и промыть нос . Полноценный душ с мытьём волос — обязательно перед сном, каждый день на неделях 1–4	Волосы удерживают наибольшее количество пыли; без мытья головы вы приносите её в постель
Э-19	Уличная одежда — в закрытый шкаф или сразу в стирку, не на спинку стула в комнате	—
Э-20	Солнцезащитные очки на улице в сезон	Снижают попадание пыли на конъюнктиву и уменьшают глазные симптомы
Э-21	Прогулки (Т-8) на неделях 1–4 — в помещении (коридор, торговый центр, беговая дорожка) либо на улице после дождя или после 20:00	Совмещает кардио-задачу с элиминацией

Поездки и перемещения

№	Правило
Э-22	На неделях 1–4 избегать поездок за город, к полям, пустырям, обочинам — местам массового произрастания амброзии
Э-23	Планировать активность на улице после дождя и в безветренную погоду
Э-24	При поездках — окна закрыты, кондиционер на рециркуляции
Э-25	Ежедневно отслеживать пыльцевую нагрузку доступным вам способом (прогноз пыления, сервисы мониторинга по региону) и записывать субъективный балл в колонку «Пыльца_симптомы_0_10»

Измеримый критерий блока: средний балл «Пыльца_симптомы_0_10» за неделю снижается относительно предыдущей недели либо держится ≤ 4 при сохраняющейся пыльцевой нагрузке. Если балл ≥ 7 два дня подряд — прогрессия останавливается (правило 8.4) и весь блок пересматривается по пунктам.

12.2. Позиционная терапия сна

Развёрнута в разделе 9.6. Здесь — только связка с общей программой: позиционная терапия имеет приоритет над наращиванием дыхательной нагрузки. Если стоит выбор между дополнительной сессией и настройкой сна на боку — настраиваем сон.

12.3. Ходьба с носовым дыханием и дозированная кардио-прогрессия

Почему это в вашем случае не «пожелание про ЗОЖ», а необходимая часть протокола. У вас нет кардионагрузок. Практика показывает, что при отсутствии аэробной нагрузки рост КП надёжно идёт до

24–26 секунд, а дальше упирается в плато. Ваша цель — 30. Значит, физическая нагрузка на носовом дыхании — обязательный компонент, а не опция. Одновременно она работает на вторичную цель № 3 (5-й этаж) и на снижение веса.

Главное правило: рот закрыт всю тренировку. Темп задаётся не пульсом и не скоростью, а сохранностью носового дыхания. Как только появилась потребность открыть рот — темп снижается до восстановления.

Прогрессия по неделям

Нед.	Формат	Объём	Условия
1–2	Ходьба ровным темпом, носовое дыхание	20 мин × 5 дней	В помещении или на улице после 20:00 / после дождя (сезон)
3–4	Ходьба, темп ускоряется до порога сохранения носового дыхания	25–30 мин × 5 дней	Там же. Добавить 1 подъём по лестнице на 5 этаж в ровном темпе, 2 раза в неделю
5–6	Ходьба + подъёмы	30–40 мин × 5 дней; лестница: 5 этажей × 2 подхода, 3 раза в неделю	Улица разрешена (сезон завершён)
7–8	Ходьба с ускорениями	40 мин × 5 дней, из них 4–6 отрезков по 2 мин в повышенном темпе на носовом дыхании; лестница 5 этажей × 3 подхода, 3 раза в неделю	—

Целевой недельный объём: к неделе 6 — не менее 150 минут ходьбы на носовом дыхании в неделю. Шаги (7 000–10 000) при этом сохраняются, но они **не засчитываются** в этот объём: бытовые шаги и целевая ходьба — разные вещи.

Тест «5-й этаж» — методика и критерии

Параметр	Как выполнять
Периодичность	1 раз в неделю, воскресенье, в одно и то же время, до еды или через 2 часа после
Исполнение	Подъём с 1-го на 5-й этаж в ровном, не ускоряющемся темпе, рот закрыт всё время , без остановок
Замеры	(1) удалось ли пройти весь подъём на носовом дыхании — да/нет; (2) ЧД сразу по прибытии, за 30 сек × 2; (3) время восстановления ЧД до исходной, сек; (4) КП через 5 минут после
Целевые значения к неделе 8	Весь подъём на носовом дыхании — да; восстановление ЧД до исходной ≤ 90 сек; КП через 5 минут — не ниже утренней минус 3 сек
Стоп внутри теста	Свист, кашель, потребность открыть рот и не удаётся закрыть, головокружение — тест прекращается, применяются правила раздела 2.4

Ограничения

- Задержки дыхания при ходьбе и на лестнице — **запрещены весь курс** (Б-4).
- В дни с ПСВ в жёлтой зоне — только спокойная ходьба 20 минут, без ускорений и лестницы.
- В дни с «Пыльца_симптомы_0_10» ≥ 6 — только в помещении.
- Разминка перед ускорениями — 5 минут спокойной ходьбы: у части людей с астмой резкое начало нагрузки провоцирует бронхоспазм.

12.4. Снижение веса

Привязка к профилю. ИМТ 27 при сильном храпе — прямой фактор сужения верхних дыхательных путей во сне. Это тот самый ограничитель, который я назвал главным в разделе 1.3. Снижение веса здесь работает не на эстетику, а на: (а) ночное дыхание и храп, (б) сухость во рту (вторичная цель № 1), (в) КП — через качество ночного дыхания, (г) одышку при подъёме.

Параметр	Значение
Целевой темп	0,3–0,5 кг в неделю. Быстрее — не нужно и вредно для приверженности
Целевой результат за курс	–3–4 кг к 27.10.2026 (ИМТ 27 → ориентировочно 25,5–26)
Ориентир по окружности талии	Измерять раз в 2 недели, утром натощак, на уровне пупка, лентой без натяжения. Цель — –3–4 см за курс. Этот показатель точнее веса отражает изменения, значимые для дыхания во сне
Взвешивание	1 раз в неделю, воскресенье, утром, после туалета, до еды, в одной и той же одежде. Ежедневное взвешивание не даёт информации и мешает
Механизм	Умеренный дефицит калорий за счёт сокращения быстрых углеводов, готовой выпечки, сладких напитков и алкоголя + белок в каждом приёме пищи + объём ходьбы из 12.3
Ограничение по ЖКБ	Резкие ограничительные диеты, голодание, интервальное голодание с длинными окнами и потеря веса быстрее 1 кг в неделю — запрещены. Быстрое снижение веса — известный фактор, ухудшающий течение желчнокаменной болезни. Регулярность приёмов пищи (12.6) здесь важнее общей калорийности

Что не делаем: не считаем это отдельным проектом с отдельной дисциплиной. Основной инструмент — блок 12.3 и режим питания 12.6, оба уже встроены в программу.

12.5. Гигиена сна

Привязка к профилю. Сон — приоритет № 2 в вашей иерархии целей, выше работоспособности. Плюс сессия 4 / вечерняя сессия — потенциальный источник нарушения засыпания, поэтому режим должен быть настроен заранее.

№	Мера	Конкретно	Обоснование
C-1	Фиксированное время подъёма	Одно и то же ± 30 мин, включая выходные	Стабильный подъём задаёт стабильное засыпание. Плюс это условие корректности утренних замеров КП и ПСВ
C-2	Целевая длительность сна	7–8 часов «в постели»	—
C-3	Отбой	Не позднее 23:30. Планируется от времени подъёма	—
C-4	Экраны	Прекратить за 60 минут до сна; вечером — тёплый свет, приглушённое освещение	—
C-5	Кофеин	Не позднее 14:00. Включая зелёный чай и матчу	48 лет + нарушенное ночное дыхание = повышенная чувствительность к остаточному кофеину
C-6	Алкоголь	Исключить полностью на весь курс	Расслабляет мышцы глотки, усиливает храп и обструкцию, ухудшает вторую половину ночи. При вашем профиле это не рекомендация, а условие работы ночного блока
C-7	Температура спальни	18–20 °C, влажность 40–50 %	Прохлада улучшает засыпание; влажность — против сухости во рту
C-8	Темнота и тишина	Плотные шторы, беруши при необходимости	—
C-9	Рабочая нагрузка	Последняя клиентская сессия — не позднее чем за 3 часа до отбоя. Не разбирать рабочие вопросы и не писать заметки по клиентам в постели	Речевая и эмоциональная нагрузка перед сном напрямую повышает время засыпания
C-10	Вечерняя дыхательная сессия	Завершается не позднее чем за 1 час до отбоя. Без Т-4, без КП «до», интенсивность 1–2	—
C-11	Если не заснули за 20–25 минут	Встать, уйти в другую комнату, тусклый свет, спокойное занятие, вернуться при сонливости. Не лежать в постели, «пытаясь заснуть»	—

№	Мера	Конкретно	Обоснование
C-12	Жидкость вечером	Основной объём — до 19:00; вечером небольшими глотками	Снижает ночные пробуждения на туалет; при этом сухость во рту решается не питьём ночью, а носовым дыханием

Измеримый контроль: «Засыпание_мин» ≤ 30 в ≥ 5 из 7 ночей; «Ночных пробуждений» ≤ 1 в среднем за неделю к неделе 8. При «Засыпание_мин» > 45 три ночи подряд — откат нагрузки по правилу 8.4, без обсуждения.

12.6. Питание и режим приёма пищи

Привязка к профилю: ЖКБ (неподвижные конкременты), избыточный вес, требование «сессии через 1,5–2 часа после еды», поздний ужин как фактор храпа.

Режим

№	Правило	Обоснование
П-1	3 основных приёма пищи + 1 перекус, в фиксированное время , без длительных голодных промежутков (> 5 – 6 часов днём)	При ЖКБ регулярное опорожнение жёлчного пузыря предпочтительнее длинных пауз. Одновременно это стабилизирует расписание сессий
П-2	Завтрак — обязателен, в течение часа после подъёма	Позволяет провести первую сессию через 1,5–2 часа, а не натощак (Б-8)
П-3	Ужин не позднее чем за 3 часа до сна , лёгкий	Полный желудок усиливает храп; поздняя еда ухудшает засыпание
П-4	Сессии — не ранее 1,5–2 ч после обычного приёма пищи, не ранее 3 ч после жирной пищи, не натощак	Б-7, Б-8
П-5	Приём пищи — с закрытым ртом, не спеша, без разговора «на ходу»	Еда торопясь и с разговором — источник аэрофагии и ротового дыхания

Состав

Категория	Что	Почему
Ограничить	Жирное жареное, крупные порции жирного за один приём, сливочные соусы, сдоба, кремовые десерты	Провокация сокращений жёлчного пузыря; вес
Ограничить	Быстрые углеводы, сладкие напитки, соки	Вес
Исключить	Алкоголь	С-6

Категория	Что	Почему
Обеспечить	Белок в каждом приёме пищи (рыба, птица, яйца, творог, бобовые при переносимости)	Удержание мышечной массы при снижении веса; сытость
Обеспечить	Овощи и клетчатка ежедневно, растительные жиры в умеренном количестве, распределённые по приёмам	Регулярный отток жёлчи; сытость
Обеспечить	Вода 1,5–2 л/сут, основной объём до 19:00	Влажность слизистых; облегчение носового дыхания
Индивидуально	Продукты с перекрёстной реактивностью к пыльце сорных трав (у части людей — бахчевые, дыня, арбуз, банан, подсолнечное семя, халва) — на неделях 1–4 отслеживать реакцию: зуд, отёчность в полости рта после употребления	Перекрёстные пищевые реакции в сезон могут усиливать общую аллергическую нагрузку. Нужен индивидуальный замер — универсального списка для вас нет, идём по вашим наблюдениям, фиксируя их в «Заметки»

БАДы

Ваш перечень (артишок, таурин, селен, куркума, индол, инозитол, лецитин, витамин D3, йод) я не отменяю и не меняю — он вне рамок этой программы. Единственное практическое замечание: **при ЖКБ добавки с желчегонным действием требуют осторожности**; если появится дискомфорт в правом подреберье (стоп-критерий Д-1), в разборе причин нужно учитывать и их, а не только дыхательную практику. Отдельно фиксируйте в «Заметки» время приёма добавок относительно сессий — при разборе плато это иногда оказывается полезным.

12.7. Ситуативная тревожность

Здесь я работаю строго в своей части — связка «параметры дыхания ↔ телесные и эмоциональные феномены» — и не даю ни базового психообразования, ни техник из вашей области. Инструментарий для работы с самим состоянием у вас свой, вы им распоряжаетесь сами.

Что важно знать о параметрах дыхания при активации

Параметр	Что происходит при ситуативной тревоге	Как это влияет на программу
Глубина вдоха	Растёт; вдох становится верхним, грудным, с подключением плечевого пояса	Минутный объём растёт, CO ₂ падает — КП в этот день ниже. Не интерпретируйте это как регресс
Частота	Растёт; появляются серии вздохов	Правило 10.3 срабатывает чаще

Параметр	Что происходит при ситуативной тревоге	Как это влияет на программу
Пауза после выдоха	Исчезает первой — раньше, чем меняются частота и глубина	Это самый ранний и самый надёжный маркёр. Исчезновение паузы можно заметить за минуты до того, как состояние станет заметным
Дыхание ртом	Появляется эпизодически, особенно при речи	Растёт сухость во рту днём
КП	Снижается на 2–5 сек в течение дня, восстанавливается на следующее утро	Не повод для отката, если ПСВ в зелёной зоне
ПСВ	Не меняется	Ключевое различие: тревога параметры бронхов не меняет. Если ПСВ упала — причина не в тревоге

Где практика Бутейко работает, а где не является инструментом

Ситуация	Работает / не работает	Что делать
Разогнанное дыхание, которое само по себе поддерживает состояние активации (частое, верхнее, с вздохами), при этом ситуация уже завершена	Работает. Уменьшенное дыхание интенсивности 1–2, 2–3 минуты, гасит именно дыхательный контур	Т-2, интенсивность 1–2. Без задержек
Дыхание сбилось непосредственно перед или во время рабочей ситуации	Работает частично. Достаточно закрыть рот и восстановить паузу после выдоха	М-1, М-4, правило 10.3
Активация нарастает, а дыхание при этом ровное	Не инструмент. Уменьшенное дыхание здесь ничего не даст, а попытка «продышать» превратит его в задачу и добавит напряжения	Технику не применять
Тревога направлена на саму задержку дыхания	Не инструмент — противопоказание. Дыхательная нагрузка усиливает реакцию	Категория Б, раздел 11.2
Поднялся эмоциональный материал	Не инструмент. Дыхательные техники прекращаются	Категория В, раздел 11.2
Паническое состояние с ощущением нехватки воздуха у человека с астмой	Не инструмент. Здесь первично различить сужение бронхов и гипервентиляцию, а не дышать по методу	Замерить ПСВ. ПСВ в зелёной зоне — бронхи проходимы. ПСВ в жёлтой/красной — работают

Ситуация	Работает / не работает	Что делать
		правила раздела 2, включая КДБА

Практическое правило дня

- **Утром:** КП — это замер, а не испытание. Если в конкретное утро вы чувствуете, что замер превращается в проверку себя, — сделайте его с секундомером экраном вниз (10.3, отдельное указание).
- **Днём:** любой всплеск активации → сначала проверьте пункт «есть ли пауза после выдоха». Если её нет — 30 секунд по правилу 10.3. Если она есть — дыхание ни при чём, техника не применяется.
- **Вечером:** вечерняя сессия при повышенной активации проводится на интенсивности 1, без задержек, либо заменяется на Т-6. Это не откат и в дневнике как откат не фиксируется.
- **Различение, которое я прошу удерживать всегда:** ощущение нехватки воздуха ≠ сужение бронхов. Единственный способ их развести — пикфлоуметр. Не заменяйте прибор ощущением, даже при вашем уровне точности его различения: при астме субъективная оценка проходимости бронхов ненадёжна у всех.

13. Дневник

13.1. CSV-шаблон

Создайте файл `дыхание_дневник_2026.csv`. Кодировка UTF-8. Разделитель — точка с запятой (так корректно открывается в русскоязычном Excel). Заголовки — ровно в таком виде и порядке, менять нельзя.

```
Дата;Слот;КП_сек;ПСВ_л_мин;Зона_ПСВ;Сессий_выполнено;Ночные_симптомы;Сухость_рта_утром;Пластырь_ночью;КДБА_применён;Засыпание_мин;Ночных_пробуждений;Храп_по_отзыву;Пыльца_симптомы_0_10;Самочувствие_0_10;Заметки
```

13.2. Пример заполненных строк

```
Дата;Слот;КП_сек;ПСВ_л_мин;Зона_ПСВ;Сессий_выполнено;Ночные_симптомы;Сухость_рта_утром;Пластырь_ночью;КДБА_применён;Засыпание_мин;Ночных_пробуждений;Храп_по_отзыву;Пыльца_симптомы_0_10;Самочувствие_0_10;Заметки
02.09.2026;Утро;20;;;Нет;Да;Нет;Нет;35;2;Сильный;7;6;Старт программы. ПСВ первый замер: 380/395/390, взяла 395. ЛЛ ещё не установлен. АСТ=19. ЧД 15/15/16, медиана 15. Ночью просыпалась в 3:40, во рту сухо.
02.09.2026;Вечер;22;390;;2;;;Нет;;;7;6;Сессия 1 (12 мин): КП до 20, после 23. Т-2 инт.2, на 3-й минуте тепло в кистях, испарина на лбу – категория А. Микро-1 и микро-3 сделаны, микро-2 пропустила. Промывание носа 3 раза. Ходьба 20 мин в коридоре ТЦ, нос всю дорогу.
16.09.2026;Утро;22;405;Зелёная;;Нет;Нет;Нет;Нет;25;0;Умеренный;4;8;ЛЛ=420
```

(сезонный), зелёная от 336, жёлтая 252–335. Первое утро без сухости во рту. Мяч между лопаток — 5-я ночь.

13.3. Правила заполнения по колонкам

Общее правило: две строки на день — «Утро» и «Вечер». Утренняя заполняется до завтрака и до препаратов, вечерняя — перед сном. Пустая ячейка допустима, если параметр к этому слоту не относится. Пропущенный день — строка всё равно создаётся с пометкой в «Заметки»: «пропуск, причина».

Колонка	Формат	Правила
Дата	ДД.ММ.ГГГГ	Заполняется всегда
Слот	Утро / Вечер / Сессия	«Утро» и «Вечер» обязательны ежедневно. «Сессия» — дополнительная строка, если нужно отдельно зафиксировать дневную сессию
КП_сек	Целое число	Утро: замер сразу после пробуждения, по протоколу 3.1. Вечер: перед сном. Если замер передержан (потребовался глубокий вдох) — записать с пометкой в «Заметки»: «передержана», в статистику не берётся. Если КП не измерялась — пусто
ПСВ_л_мин	Целое число	Лучшая из 3 попыток. Недели 1–2 и все дни с симптомами — оба слота. Недели 3–8 без симптомов — утро. Три исходные цифры пишутся в «Заметки». Замер после КДБА — не сюда, а в «Заметки» с пометкой «после КДБА»
Зона_ПСВ	Зелёная / Жёлтая / Красная / пусто	До установления личного лучшего (до 15.09) — пусто. После — рассчитывается по таблице 3.2. При пересчёте ЛЛ на неделях 5–6 — новые границы, старые строки не пересчитываются
Сессий_выполнено	Целое число или R	Сколько полных сессий выполнено за день (микропрактики не считаются). R — день проведён в редуцированном объёме (8.5). 0 — практики не было
Ночные_симптомы	Нет / текст	Заполняется в утреннем слоте за прошедшую ночь. При наличии — что именно: кашель, свист, стеснение в груди, пробуждение от нехватки воздуха. Последнее — стоп-критерий, немедленный follow-up
Сухость_рта_утром	Да / Нет	Утренний слот. Ключевой показатель вторичной цели № 1. Оценивается в момент пробуждения, до питья

Колонка	Формат	Правила
Пластырь_ночью	Нет / Да / Проба	На неделях 1–8 по умолчанию Нет (раздел 9.1). Проба — дневная или вечерняя проба в бодрствовании. Да — только при выполнении условий 9.3
КДБА_применён	Нет / Да, N раз	Заполняется в обоих слотах. При Да — обязательно причина, время и ПСВ через 20–30 мин в «Заметки». Любое Да = прогрессия стоп + follow-up
Засыпание_мин	Целое число	Утренний слот, оценка за прошедшую ночь. Не смотрите на часы ночью — оценивайте ретроспективно, ± 10 мин достаточно. > 45 три ночи подряд = откат
Ночных_пробуждений	Целое число	Утренний слот. Считаются все пробуждения, включая на туалет. В «Заметки» — с чем связано, если известно
Храп_по_отзыву	Нет / Слабый / Умеренный / Сильный / Нет данных	По отзыву присутствующих либо по записи с диктофона (минимум 2 ночи в неделю). Нет данных — допустимо, но не чаще 3 раз в неделю
Пыльца_симптомы_0_10	0–10	Суммарная выраженность за сутки: заложенность, чихание, зуд глаз и носа, отделяемое. 0 — нет; 10 — максимально выражено. ≥ 7 два дня подряд = прогрессия стоп
Самочувствие_0_10	0–10	Общее состояние за сутки. 0 — крайне плохо, 10 — отлично. ≤ 4 три дня подряд без респираторных симптомов = откат по объёму (правило 7.3)
Заметки	Свободный текст	См. ниже

Правила для колонки «Заметки» — расширенные

Это самая информативная колонка. Формат — короткие смысловые блоки через точку. Что фиксировать обязательно:

№	Что	Пример формулировки
1	Три исходные попытки ПСВ	ПСВ 380/395/390
2	КП «до/после» каждой сессии	С1: КП до 21, после 25
3	Какие техники и какая интенсивность	Т-2 инт.2, 3 цикла по 3 мин; Т-3 $\times 2$
4	Отработанные напоминания	Р-1, Р-3 сделаны, Р-2 пропущено

№	Что	Пример формулировки
5	Ходьба	Т-8 30 мин, нос всю дорогу, 1 раз открыла рот на подъёме
6	Срабатывания стоп-критериев и действия	Головокружение на 4-й минуте цикла 2 – сессия прекращена
7	Внешние факторы	Ветер, сухо, пыление сильное. Проветривала после 22:00
8	Еженедельные показатели	ЧД 13 (медиана из 3). Вес 74,2. Талия 89. Тест 5-й этаж: нос – да, восстановление 110 сек
9	Телесные и эмоциональные феномены сессии	См. ниже

Отдельно — про феномены. Это диагностически ценно, и вот почему я прошу их фиксировать: по их характеру и привязке к фазе сессии я вижу то, чего не видно по цифрам, — корректность исполнения техники, реальную (а не заявленную) интенсивность нагрузки и момент, когда сессия перестаёт быть дыхательной практикой. Три цифры КП без этой информации интерпретируются гораздо хуже.

Формат записи — короткий и структурированный, четыре элемента:

— — —

Примеры:

- А – цикл 2, 3-я мин – тепло в кистях и стопах, испарина на лбу, слюноотделение – продолжила, довела цикл
- А – цикл 3, 2-я мин – покалывание вокруг рта, включились лестничные мышцы – снизила до инт.1, ушло за 40 сек
- Б – начало Т-4 – сжатие под ключицами, дыхание ускорилось раньше задержки – задержку не делала, перешла на Т-2 инт.1. Задержки на 5 дней сняты
- В – фаза покоя после цикла 2 – ком в горле, волна жара, слёзы – технику остановила, свободное дыхание, сессию не возобновляла. КП после не мерил

Содержание материала категории В фиксировать **не нужно** — только метка, фаза и влияние на выполнение.

13.4. Недельная сводка

Заполняется каждое воскресенье вечером, 10 минут. Отдельный лист/файл. Это то, что вы присылаете в follow-up.

Шапка: Неделя № __ , даты __. __ – __. __ , фаза __ , трек __ , уровень нагрузки (последняя ступень прогрессии) __

Агрегаты

Показатель	Как считать	Значение	Дельта к прошлой неделе
КП утренняя, среднее	Среднее по 7 утренним замерам (передержанные исключить)		
КП утренняя, мин–макс			
КП утренняя, разброс	макс – мин; норма ≤ 4 сек		
КП «после – до», среднее	По всем сессиям недели; целевое $\geq +2$ сек		
ПСВ утренняя, среднее			
ПСВ, минимум за неделю			
Дней в зелёной зоне	из 7		
Вариабельность ПСВ	(макс – мин) $\div$ ЛЛ $\times 100$ %, по дням с двумя замерами		
Сессий выполнено	Сумма за неделю / плановое число		
Приверженность	% дней, где выполнен минимум для зачёта дня		
Ночей с сухостью во рту	из 7		
Засыпание, среднее	мин		
Ночных пробуждений, среднее	за ночь		
Ночей «Храп = Сильный»	из 7		
Пыльца, средний балл			
Самочувствие, средний балл			
КДБА применён	дней из 7		
Ходьба на носовом дыхании	суммарно мин за неделю		
ЧД в покое (воскресенье)	/мин		
Вес / талия	раз в 2 недели		

Отклонения

Что фиксируется	Формат
Срабатывания стоп-критериев	Дата, какой критерий, что сделала, результат
Дни в жёлтой зоне	Даты, показатель, предполагаемая причина
Откаты и их причина	Дата, с какой ступени на какую
Пропущенные дни	Даты, причина
Феномены категорий Б и В	Даты, метки (без содержания)
Плато	Отмечается, если КП не растёт ≥ 7 дней

Вывод недели — одна строка

Прогрессия разрешена / прогрессия остановлена / откат выполнен + основной ограничитель недели: _____

14. Follow-up

14.1. Регламент

Тип	Когда	Что делаю я
Базовый	Раз в 2 недели — только при наличии отклонений (см. блок «Отклонения» в недельной сводке). Если отклонений нет — отправка не требуется, работаете по плану	Возвращаю решение о прогрессии и точечные поправки
Плановая точка 1	Конец недели 4, 29.09.2026 — обязательно, независимо от отклонений	Полный разбор сезонной фазы, перевод в фазу роста
Плановая точка 2	Конец недели 8, 27.10.2026 — обязательно	Итог курса, решение по продолжению
Немедленный	При срабатывании любого стоп-критерия — в течение 24 часов	Решение о возобновлении, объёме, необходимости очного обращения
По плато	КП не растёт 10 дней подряд в фазе роста (Ф3, Ф4)	Разбор по алгоритму 8.6, назначение конкретного рычага

Дополнительные обязательные триггеры (добавляю к вашему списку):

№	Триггер
T-1	Любое применение КДБА
T-2	ПСВ в жёлтой зоне 2 дня подряд или 4 дня из 7

№	Триггер
T-3	Вариабельность ПСВ «утро–вечер» > 20 % два дня подряд (Д-5)
T-4	Появление ночных симптомов, которых не было (Д-6)
T-5	«Сухость_рта_утром» = Да в ≥ 4 из 7 ночей на конец недели 4, при полном выполнении блока 9.6
T-6	Феномены категории Б (тревога на задержку) — 2 и более раза за 7 дней
T-7	Готовность вводить пластырь: получено заключение по исследованию сна

14.2. Что присылать

Стандартный пакет (базовый и плановый follow-up):

№	Что	Формат
1	CSV-дневник за период	файл
2	Недельные сводки за период	таблица, заполненная
3	Текущий личный лучший ПСВ и рассчитанные границы зон	3 числа
4	Текущий трек, текущая ступень прогрессии, дата последнего шага	строка
5	Перечень срабатываний стоп-критериев за период и что было сделано	список
6	Метки феноменов (А/Б/В) с привязкой к фазе сессии — без содержания	список
7	ЧД в покое за каждую неделю периода	числа
8	Ходьба: минуты в неделю; результат теста «5-й этаж»	числа
9	Один вопрос или наблюдение, которое вы считаете важным	свободно

Дополнительно к плановой точке недели 4 (29.09.2026): повторный АСТ (сумма и ответы по 5 пунктам); вес и талия; результаты пройденных обследований (спирометрия, исследование сна), если уже есть.

Дополнительно к плановой точке недели 8 (27.10.2026): всё вышеперечисленное + итоговый тест «5-й этаж» + сравнительная таблица «baseline → итог» по всем целевым метрикам из раздела 1.2.

Немедленный follow-up (сокращённый, чтобы не терять время):

№	Что	Пример
1	Какой стоп-критерий, дата и время	07.10, 09:40, свист на 3-й минуте цикла 2
2	Что делали и чем закончилось	Прекратила, 10 мин покоя, свист ушёл без КДБА

№	Что	Пример
3	ПСВ: до события (утро), после события, через 30 мин	410 / 340 / 375
4	КП утренняя за последние 5 дней	24, 23, 24, 22, 21
5	Текущая ступень нагрузки и дата последнего повышения	П-4 (инт. 2-3), повышено 04.10
6	Пыльца, ночные симптомы, КДБА за последние 3 дня	коротко
7	Базисная терапия принималась в полном объёме?	Да / Нет + что пропущено

Follow-up по плато: стандартный пакет + заполненный чек-лист шагов 1–6 алгоритма 8.6 (что проверено и что найдено).

14.3. Что я возвращаю

Тип обращения	Срок ответа	Состав ответа
Базовый / плановый	до 3 рабочих дней	1) Вердикт по прогрессии: разрешена / остановлена / откат, с указанием ступени и даты следующей проверки. 2) Разбор техники по вашим меткам феноменов и цифрам КП «до/после» — что выполняется неверно. 3) Обновлённые границы зон ПСВ, если пересчитан личный лучший. 4) Решение по треку (А/В/смешанный). 5) Корректировка фазового плана на следующие 2 недели с конкретными числами. 6) Решение по ночному компоненту
Немедленный	в течение 24 часов	1) Продолжать / редуцированный объём / полная остановка. 2) Условия и дата возврата к прогрессии по правилу 2.6. 3) Нужно ли очное обращение и в какой срок. 4) Что изменить в блоке элиминации/сна немедленно
По плато	до 2 рабочих дней	1) Определение ограничителя (ночное дыхание / техника / аэробная нагрузка / дневной фон / аллерген). 2) Один конкретный рычаг с числовым заданием на 7–10 дней. 3) Решение о разгрузочной неделе. 4) При необходимости — пересмотр сроков цели (не величины)
Точка недели 8	до 3 рабочих дней	Итоговое заключение: достигнутые значения против baseline по всем метрикам, что сработало и что нет, программа на недели 9–16

15. Как это работает, обследования и допущения

15.1. Физиология метода — кратко и по существу

Исходная посылка метода. При хроническом избыточном дыхании (гипервентиляции — дыхании, превышающем метаболическую потребность) из крови вымывается углекислый газ. Развивается **гипокапния** — снижение содержания CO_2 в крови. Метод ВЛГД направлен на то, чтобы вернуть дыхание к меньшему минутному объёму и тем самым повысить содержание и переносимость CO_2 .

Почему это может быть значимо именно при астме:

Механизм	Что происходит
CO_2 и тонус гладкой мускулатуры бронхов	Углекислый газ обладает бронхорасширяющим действием; снижение его содержания сопровождается повышением тонуса бронхов. Отсюда классическое наблюдение: форсированное глубокое дыхание у человека с астмой способно ухудшить состояние, а не улучшить
Эффект Бора	Отдача кислорода тканям из гемоглобина зависит от содержания CO_2 : при выраженной гипокапнии кислород хуже отделяется от гемоглобина, и насыщение крови кислородом при этом остаётся нормальным. Это объясняет, почему при частом глубоком дыхании может возникать субъективное ощущение нехватки воздуха при нормальных показателях кислорода
Носовое дыхание	Нос согревает, увлажняет и фильтрует воздух; фильтрация части пылевых частиц значима в сезон. Дыхание ртом лишает дыхательные пути этой обработки — холодный сухой воздух является известным провокатором бронхоспазма
Диафрагмальный паттерн	Спокойное дыхание с работой диафрагмы и пассивным выдохом требует меньше усилий, чем верхнегрудное с участием вспомогательных мышц, и сопровождается меньшей общей активацией
Ночное дыхание	Ротовое дыхание во сне сушит слизистые, усиливает храп и является фактором ночных симптомов. Восстановление носового дыхания ночью — единственный способ повлиять на 7–8 часов, которые никакой дневной практикой не покрываются

Почему растёт КП. Контрольная пауза отражает не «объём лёгких» и не «выносливость», а порог, при котором накопление CO_2 вызывает позыв к вдоху. Уменьшая избыточную вентиляцию в течение дня, вы постепенно смещаете этот порог — и КП растёт как **следствие**. Именно поэтому КП не тренируют напрямую: терпеть задержку дольше — значит менять цифру, не меняя дыхание.

Что честно нужно сказать о доказательной базе. Данные о влиянии дыхательных техник, включая метод Бутейко, на **симптомы и качество жизни** при астме существуют и в целом положительны. Данных о том, что метод улучшает **объективные показатели функции лёгких или уменьшает воспаление в бронхах**, — нет. Из этого следует прямое практическое правило, ещё раз: **метод работает поверх базисной терапии и не является поводом её сокращать**. Пульмикорт, Монтелукаст, Цетрин и Нозефрин делают то, чего дыхательная практика не делает вообще. Любые числовые нормативы «правильного CO_2 » и «нормы КП», которых я не могу подтвердить, я вам намеренно не привожу — работаем от вашей индивидуальной динамики.

Что реалистично ожидать от курса: уменьшение ротового дыхания днём и ночью, уменьшение сухости во рту, снижение частоты дыхания в покое, лучшая переносимость нагрузки на носовом дыхании, рост КП, снижение частоты «дыхательного дискомфорта». Чего ожидать не следует: отмены препаратов, исчезновения аллергии, купирования приступа дыханием.

15.2. Рекомендованные обследования

Приоритет	Обследование	Срок	Зачем именно вам	Что изменится в программе
1	Спирометрия с оценкой ОФВ1 и пробой с бронхолитиком (измерение объёмов и скоростей дыхания до и после ингаляции расширяющего бронхи препарата)	В течение 2–4 недель, оптимально — до конца сезона, ~до 29.09.2026	Единственный объективный показатель функции лёгких у вас отсутствует. ПСВ — полезный, но грубый инструмент; она не различает обструкцию по уровню и хуже отражает состояние мелких бронхов	Появится точка отсчёта для оценки безопасности прогрессии; станет возможен более быстрый переход в фазу роста
2	Респираторный мониторинг сна (портативное исследование дыхания во сне) или полисомнография	В течение 4–6 недель, оптимально к концу недели 4	Сильный храп + ИМТ 27 + возраст 48 + ночная сухость во рту. СОАС не исключён. Это, по моей оценке, главный ограничитель роста КП в вашем случае, и он же — единственное препятствие к ночному компоненту	Снимет или подтвердит запрет на пластырь (9.1). При выявлении апноэ вся ночная часть программы перестраивается, а цель по КП получает объяснение своего потолка
3	АСТ	02.09.2026 — сегодня, далее 29.09 и 27.10	Формализованная оценка контроля астмы; служит фильтром для старта прогрессии (3.3)	При АСТ < 20 прогрессия не начинается
4	Консультация аллерголога по вопросу плановой подготовки к сезону 2027 (вне рамок текущего курса)	После окончания сезона, октябрь–ноябрь 2026	Ваша программа стартовала в пик пыления — худший из возможных вариантов. Следующий сезон имеет смысл	Позволит планировать курс 2027 года с фазой роста, не совпадающей с сезоном

Приоритет	Обследование	Срок	Зачем именно вам	Что изменится в программе
			встретить подготовленной	
5	Общий анализ крови, уровень витамина D — при плановом обследовании	В удобный срок	Общая оценка фона; вы принимаете D3	Не влияет на протокол напрямую

Важно: ни одно из этих обследований не блокирует старт программы сегодня. Программа спроектирована так, чтобы работать при их отсутствии — за счёт консервативных ограничений (запрет максимальных задержек, запрет пластыря, ПСВ-контроль дважды в сутки на старте).

15.3. Допущения

Здесь честно перечислено то, что я додумал за вас, и на чём построен протокол. Если какое-то допущение неверно — сообщите, и я скорректирую соответствующую часть.

№	Допущение	На что влияет	Что делать, если неверно
Д-1	Астма контролируется: КДБА не используется, ночных симптомов нет, АСТ ≥ 20	Разрешение стартовать программу вообще	При АСТ < 20 — старт только в объёме недель 1–2, без прогрессии (3.3)
Д-2	Личный лучший ПСВ, полученный в сезон, занижен относительно вашего истинного	Пересчёт зон на неделях 5–6	Если пересчёт не даст прироста — работаем от сезонного значения
Д-3	Храп связан преимущественно с ротовым дыханием и положением на спине , а не с выраженным апноэ	Ночной блок построен на позиционной терапии, а не на аппаратном лечении	При выявлении апноэ ночной блок перестраивается полностью
Д-4	Baseline КП 20 сек измерен корректно — утром, до подъёма, до первого позыва	Вся система целей и порогов	Если первые 3 замера по протоколу 3.1 дадут другую цифру — baseline переопределяется, цель 30 сохраняется, сроки пересматриваются в follow-up
Д-5	ЧД ~16/мин занижена или завышена , реальное значение будет получено 02–04.09 по методике 3.4	Вторичная цель № 2	Целевой коридор 10–12/мин сохраняется в любом случае

№	Допущение	На что влияет	Что делать, если неверно
Д-6	Пульмикорт через небулайзер применяется 1–2 раза в сутки , точная схема мне не сообщена	Тайминг замеров ПСВ и сессий (Б-11)	Пришлите фактическую схему — скорректирую расписание дня
Д-7	Рабочий график: клиентские сессии в интервале 10:00–18:30, с перерывами; подъём ~07:00, отбой ~23:00	Всё расписание разделов 5, 6, 10	Пришлите реальный график — расписание перестраивается за один шаг
Д-8	Конкременты в жёлчном пузыре бессимптомны , эпизодов колики не было	Разрешение на диафрагмальную работу с малой амплитудой (2.2)	При наличии эпизодов боли в анамнезе — амплитуда не расширяется всю программу
Д-9	Дома есть человек, способный оценить храп , хотя бы часть ночей	Колонка «Храп_по_отзыву»	Замена — запись на диктофон 2 ночи в неделю
Д-10	Ситуативная тревожность не связана с дыханием и не имеет панического компонента с ощущением удушья	Раздел 11 и 12.7	При наличии эпизодов с ощущением удушья — задержки Т-4 исключаются из программы полностью
Д-11	Есть техническая возможность обеспечить очиститель воздуха, гигрометр, секундомер, весы	Блоки 12.1, 12.4, 12.5	При отсутствии очистителя усиливаются меры Э-2, Э-4, Э-5, Э-8
Д-12	Программа выполняется поверх базисной терапии без изменений доз и схем	Всё	—

16. Когда обращаться к очному врачу: красные флаги

Раздел написан протокольно.

16.1. Немедленно — экстренная медицинская помощь

Дыхательные техники не применяются. КДБА — по инструкции, одновременно с вызовом помощи.

№	Признак
1	Затруднение речи из-за одышки: невозможно произнести целую фразу на одном выдохе

№	Признак
2	Синеватый оттенок губ, кончиков пальцев
3	Спутанность, заторможенность, выраженное возбуждение на фоне одышки
4	Отсутствие или кратковременность эффекта КДБА при выраженной одышке
5	ПСВ ниже 60 % от личного лучшего, не поднимающаяся после КДБА
6	Одышка в покое, нарастающая
7	Втяжение межрёберных промежутков и надключичных ямок при дыхании
8	Боль в грудной клетке давящего характера, особенно с отдачей в руку, челюсть, спину; резкая слабость; холодный пот
9	Обморок или предобморочное состояние
10	Интенсивная боль в правом подреберье или верхней части живота, не проходящая за 30 минут, особенно с тошнотой, рвотой, температурой, желтушностью кожи или склер, потемнением мочи

16.2. В течение 24 часов — очное обращение к врачу

Программа при этом останавливается.

№	Признак
1	Любой стоп-критерий раздела 2.3 повторился 2 дня подряд
2	Утренняя ПСВ ниже 60 % от личного лучшего (однократно)
3	Потребность в КДБА возникла впервые за курс либо возникает повторно
4	Ночное пробуждение от нехватки воздуха
5	Ночные симптомы астмы, которых ранее не было (кашель, свист, стеснение в груди), 2 ночи подряд
6	Свистящее дыхание в покое, не связанное с упражнениями
7	Температура выше 38 °С с кашлем, отделяемым, болью в грудной клетке
8	Эпизод боли в правом подреберье длительностью более 15 минут, прошедший самостоятельно

16.3. В плановом порядке (в течение 1–2 недель)

№	Признак
1	Утренняя ПСВ в жёлтой зоне (60–79 %) 4 дня из 7 и более
2	Вариабельность ПСВ «утро–вечер» более 20 % в течение 3 дней и более

№	Признак
3	Постепенное нарастание потребности в контроле дыхания, ощущение ухудшения переносимости нагрузки в течение 2 недель
4	Стойкая заложенность носа, не поддающаяся промыванию и назначенной терапии, более 10 дней
5	Отсутствие улучшения по «Сухость_рта_утром» к концу недели 4 при полном выполнении блока 9.6
6	Дневная сонливость, эпизоды засыпания в неподходящих ситуациях, свидетельские наблюдения остановок дыхания во сне — независимо от прочих показателей
7	Кровь в мокроте, необъяснимое снижение веса, стойкая осиплость — вне зависимости от дыхательной программы

16.4. Правило, действующее всегда

Дыхательная программа никогда не имеет приоритета над обращением за медицинской помощью. При сомнении между «продолжить по протоколу» и «обратиться к врачу» выбирается обращение к врачу. Метод Бутейко не является средством купирования приступа бронхиальной астмы и не заменяет препарат скорой помощи.

Вопросы к пациентке

Пять вопросов, только критичные для безопасности, по убыванию важности. Ответы нужны до конца недели 1 — они меняют конкретные параметры протокола.

№	Вопрос	Почему это критично	Что изменится в протоколе
1	Были ли за последние 12 месяцев эпизоды с ощущением удушья или нехватки воздуха вне связи с астмой — на фоне эмоционального напряжения, в покое, ночью, с сердцебиением и ощущением, что «не хватает вдоха»? Если да — сколько раз и чем заканчивались?	Это единственный вопрос, ответ на который может полностью снять из программы блок задержек дыхания. При наличии эпизодов с субъективным удушьем повторные задержки закрепляют реакцию (категория Б, раздел 11.2) и одновременно затрудняют различение «сузились бронхи / разогналось дыхание» — а при астме это различение и есть основа безопасности	Да → Т-4 и любые задержки, кроме диагностической КП и малых пауз Т-3, исключаются из курса полностью; рост КП обеспечивается Т-2, Т-8 и ночным блоком; КП замеряется с секундомером экраном вниз. Нет → протокол без изменений

№	Вопрос	Почему это критично	Что изменится в протоколе
2	Точная схема Пульмикорта: сколько раз в сутки, в какое время, какая доза, курс на какой срок назначен? Принимаются ли Монтелукаст, Цетрин и Нозефрин в полном объёме, без пропусков, последние 2 недели?	Весь тайминг замеров и сессий привязан к ингаляциям (Б-11, раздел 3.2). При этом пропуски базиса — самая частая причина падения ПСВ, которую ошибочно списывают на дыхательную практику; без точной схемы я не смогу корректно разобрать ни одно срабатывание стоп-критерия	Уточнение расписания дня в разделах 5.1 и 6.1; при выявленных пропусках базиса — прогрессия не начинается до 7 дней полного приёма
3	Кто-либо когда-либо наблюдал у вас во сне остановки дыхания, резкие всхрапывания с пробуждением, паузы в храпе? Бывают ли эпизоды непроизвольного засыпания днём — за рулём, на совещании, при чтении?	Прямо влияет на допустимость ночного компонента (раздел 9.1) и на приоритет обследования сна. Ваш профиль (ИМТ 27, сильный храп, 48 лет) уже относит СОАС к вероятному; свидетельские паузы или дневные засыпания переводят обследование сна из «приоритет 2» в «сделать в ближайшие 2 недели»	Да по любому пункту → респираторный мониторинг сна становится первоочередным, пластырь исключается из курса безусловно, ночной блок усиливается, ожидаемый потолок КП пересматривается
4	Каким был тот приступ астмы в анамнезе: когда, что послужило провокатором, потребовалась ли неотложная помощь, госпитализация, системные гормоны? Были ли обострения за последние 12 месяцев?	Тяжесть предшествующих обострений определяет допустимую агрессивность прогрессии. Эпизод с неотложной помощью, госпитализацией или системными гормонами в анамнезе — основание работать на минимальных шагах весь курс независимо от текущих хороших показателей	Тяжёлый эпизод в анамнезе → шаг прогрессии удлиняется с 5 до 7 дней, интенсивность воздушного голода ограничивается уровнем 2 весь курс, максимальная пауза исключается даже на неделях 7–8, ПСВ 2х/сут постоянно
5	Были ли эпизоды боли или тяжести в правом подреберье — когда-либо, включая кратковременные? Как давно и по какому поводу были обнаружены конкременты, есть ли актуальное УЗИ (давность), и указан ли в заключении	Допущение Д-8 (конкременты бессимптомны) — основание для разрешения диафрагмальной работы с расширением амплитуды с недели 3 (раздел 2.2). Если эпизоды боли были, амплитуда не расширяется всю программу	Были эпизоды → амплитуда диафрагмальной работы остаётся минимальной все 8 недель, критерий Д-1 ужесточается (однократный эпизод = пауза программы), сессии — не ранее 3 часов после любого приёма пищи

№	Вопрос	Почему это критично	Что изменится в протоколе
	размер камней и состояние стенки пузыря?		

Что делать прямо сейчас — порядок действий на 02.09.2026

№	Действие	Раздел	Время
1	Проверить срок годности КДБА, положить в комнату для практики	Б-2	2 мин
2	Пройти АСТ, записать сумму	3.3	5 мин
3	Первый замер ПСВ (3 попытки), записать все три	3.2	5 мин
4	Замер ЧД в покое, 3 подхода, записать медиану	3.4	20 мин
5	Развернуть CSV-дневник, внести первую строку	13.1– 13.2	10 мин
6	Запустить блок элиминации аллергена — сегодня же, до первой сессии: закрыть окна, промывание носа, вечером душ с мытьём головы, смена белья, мяч между лопаток на ночной футболке	12.1, 9.6	вечер
7	Поставить 4 повторяющихся напоминания в телефоне (11:00, 15:00, 17:00, 21:00)	10.2	3 мин
8	Записаться на спирометрию и на исследование сна	15.2	—
9	Ответить на 5 вопросов выше	—	—
10	Первая дыхательная сессия — завтра утром, 03.09 , трек В, сессия 1 (12 мин). Сегодня — только замеры и режимные меры	6.2	—

Утренняя КП завтра, 03.09, — сразу после пробуждения, до подъёма с кровати, по протоколу 3.1. Это ваш первый корректно измеренный baseline; дальше всё считаем от него.

Резюме документа в трёх строках: Недели 1–4 — это не разгон, а удержание в пик амброзии, набор baseline ПСВ и постановка техники; рост КП планируется на недели 5–8. Ночное дыхание — главный ограничитель вашего результата, и работаем мы с ним позиционной терапией и носовой проходимостью, а не пластырем. Прогрессия делается только тогда, когда все восемь условий раздела 8.3 выполнены одновременно — по цифрам дневника, а не по самочувствию.

Документ версии 1.0 от 02.09.2026. Обновляется по итогам follow-up недели 4 (29.09.2026) — версия 1.1, и недели 8 (27.10.2026) — итоговая версия 2.0.